0:00
Я пока здесь и никуда не отключаюсь.
0:03
3 секунды
Спасибо. Спасибо, Слава Миха. Ну вот и и ещё хочу сказать тоже слушателям,
0:07
7 секунд
которые к нам сейчас подсоединились, что у вас в расписании 4 апреля будет продолжение вебинаров и на и 4 апреля у
0:17
17 секунд
вас будет вебинар, который будет посвящён, Сейчас скажу, почему. будет
0:25
25 секунд
тоже интересный очень вебинар. А минорные биологические активные вещества, их роль в обеспечении активного долголетия. При
0:34
34 секунды
этом, а мы немножко меняем аа стратегию реализации
0:41
41 секунда
вебинаров. У нас лекционный материал читает преподаватель одна. Вебинар проводит другой преподаватель,
0:51
51 секунда
который также как и лектор имеет отношение к минорным биологическим веществам, добавкам. А и я думаю, что вам будет крайне интересно её послушать.
1:02
1 минута 2 секунды
Это спикер наших конференций по здоровому долголетию Солнцева Татьяна Николаевна.
1:09
1 минута 9 секунд
Поэтому тоже, я думаю, вам будет крайне интересно её и послушать, и тоже задать вопросы, потому что она эксперт в этом направлении. А всё-таки это направление,
1:19
1 минута 19 секунд
оно очень практикориентированное,
1:21
1 минута 21 секунда
особенно в деятельности наших специалистов, поэтому тоже имейте этот момент в виду. Так, я тогда выключаюсь,
1:30
1 минута 30 секунд
пока я с вами и наблюдаю, что происходит. Хорошо, спасибо, спасибо.
5:03
5 минут 3 секунды
Наверное, будем начинать. Я так думаю,
5:05
5 минут 5 секунд
пока я представлюсь, может быть, кто-то ещё к нам присоединится, я так думаю.
5:11
5 минут 11 секунд
Ну, в любом случае, все, кто здесь, я рада вас приветствовать. Меня зовут Аракелян Самали Ашотовна. Я доцент кафедры
5:19
5 минут 19 секунд
общейврачебной практики Сечиновского университета. И мне очень приятно сегодня с вами разобрать интересную,
5:27
5 минут 27 секунд
очень интересную тему, которая касается лабораторной и инструментальной диагностики в профилактике возраст
5:34
5 минут 34 секунды
зависимых заболеваний. Если вы позволите, я сейчас пока начну демонстрацию, и мы с вами, а, сразу же,
5:46
5 минут 46 секунд
так, это я всё сворачиваю, и мы с вами всё будем вместе смотреть. Значит,
5:58
5 минут 58 секунд
сразу скажу, как раз всё. Надеюсь, вам всё видно, слышно.
6:04
6 минут 4 секунды

Сразу скажу, что если у вас будут какие-то вопросы по ходу моей презентации или после, в любом случае, я всегда открыта к диалогу любой вопрос,
6:15
6 минут 15 секунд
вы можете хоть и остановить меня сразу задать или написать в чате абсолютно,
6:21
6 минут 21 секунда
как вам удобно. Или вы осознали там, что хотели спросить позже, напишите мне позже. Если что-то я в чём-то там буду
6:29
6 минут 29 секунд
сомневаться или не знать точный ответ, я отвечу вам его после. не пришлю обязательно. Поэтому максимально
6:36
6 минут 36 секунд
стараемся взаимодействовать. И я готова к любым вопросам. Я постаралась тоже максимально выложить здесь всю
6:45
6 минут 45 секунд
информацию, скажем так, больше с такой практической точки зрения, чтобы вам это было нужно в вашей практике, да, и
6:52
6 минут 52 секунды
какие-то вот говорить об этом-то можно очень много, но какие-то базовые, а,
6:57
6 минут 57 секунд
базовые знания. Я надеюсь, что я вот здесь вот постаралась всё это вместе соединить и вам это всё предоставить.
7:05
7 минут 5 секунд
А что я хочу, да, чтобы мы на этом вебинаре в первую очередь, конечно же, проговорили о лабораторной диагностике,
7:12
7 минут 12 секунд
да, мы определим и проговорим основные показатели лабораторных исследований,
7:18
7 минут 18 секунд
да, вот конкретно абсолютно тех, на которые мы должны ориентироваться, на какие показатели и
7:25
7 минут 25 секунд
как мы должны их интерпретировать и связывать с тем или иным заболеванием.
7:30
7 минут 30 секунд
Но обязательно проговорим об алгоритме назначения лабораторных исследований.
7:35
7 минут 35 секунд
Проговорим не только лабораторные, но и необходимость назначения функциональных и инструментальных методов исследования.
7:43
7 минут 43 секунды
Конечно же, в профилактике таких наиболее распространённых возраст зависимых заболеваний. Ну и проговорим,
7:49
7 минут 49 секунд
конечно же, алгоритм назначений, да, вот таких вот периодических исследований и лабораторных, и функциональных. Прежде
7:58
7 минут 58 секунд
мы коснёмся, да, изучения и разберём основные показатели клинического и биохимического анализа в крови,
8:05
8 минут 5 секунд
поговорим, конечно же, о показателях мочи и копрограммы, проговорим и разберём, да,
8:11
8 минут 11 секунд
основные виды инструментального обследования, разберём примеры заключений и будем пробовать как бы
8:18
8 минут 18 секунд
сформулировать рекомендации и проговорим вот именно алгоритм назначения лабораторной и инструментальной
8:25
8 минут 25 секунд
диагностики. Итак, клинический анализ крови. Начнём, пожалуй, с него. И начну с того, что действительно, ну, это тот,
8:33
8 минут 33 секунды
наверное, самый простой, самый доступный, но в то же время очень информативный анализ, да. Это тот

8:40
8 минут 40 секунд
анализ, по которому с которого, скажем так, мы начинаем любое обследование, мы начинаем профилактические всякие осмотры, диспансеризацию, чекапы, но мы
8:50
8 минут 50 секунд
начинаем именно с клинического или общего, как хотите, анализа крови.
8:55
8 минут 55 секунд
Обратите внимание, что любой патологический процесс влияет на количество и качество форменных
9:02
9 минут 2 секунды
элементов крови. Поэтому именно то, что мы можем ещё, вернее, уже заподозрить на самых ранних стадиях, когда болезнь ещё
9:10
9 минут 10 секунд
не манифестировала, когда основные её проявления не ещё не зарегистрированы,
9:16
9 минут 16 секунд
мы можем уже обнаружить изменения по клиническому анализу крови. Но это действительно тот доступный анализ,
9:23
9 минут 23 секунды
скажем так, первичной диагностики,
9:26
9 минут 26 секунд
скрининга, мониторинга, который может исследоваться, использоваться, вернее,
9:32
9 минут 32 секунды
вот в этих целях. Мы действительно можем диагностировать и выявить целый ряд заболеваний уже по клиническому анализу
9:40
9 минут 40 секунд
крови, да? Это те же вирусные и бактериальные инфекции, аллергические состояния, паразитозы, анемию,
9:47
9 минут 47 секунд
безусловно, различных видов мы тоже можем оценить с помощью клинического анализа крови. Дегидратация, воспаление,
9:55
9 минут 55 секунд
лейкемия, низкий, высокий уровень тромбоцитов. Ну и, конечно же, оценить мониторинг, провести эффективность,
10:02
10 минут 2 секунды
контроль проводимого лечения. Какие основные показатели? Да, я специально здесь выделила основные показатели общего анализа крови. Мы немножечко
10:10
10 минут 10 секунд
остановимся на каждом, но это как бы общие такие показатели. Специально показала их сокращение. Иногда тоже пишут, вызывает вопросы. Ну вот это вот
10:19
10 минут 19 секунд
такие сокращения, на которые мы тоже должны ориентироваться. Ну вот кровь составляет примерно 8% от массы тела человека. состоит кровь из клеток,
10:30
10 минут 30 секунд
клеточных фрагментов, так называются тромбоциты и плазма. И вот эта доля клеточных элементов в общем объёме носит
10:37
10 минут 37 секунд
название гематокрит. Это тоже один из показателей крови. Итак, эритроциты.
10:43
10 минут 43 секунды
Начнём с них, потому что это основной пул клеток крови. Больше 99% из всех клеток крови составляет
10:50
10 минут 50 секунд
именно эритроциты. Я привожу здесь некие усреднённые референсные значения. Будет так везде. Останавливаться не буду. Просто это, безусловно, усреднённы,
10:59
10 минут 59 секунд

потому что, вы знаете, каждая лаборатория работает со своей аппаратурой, со своими там формулами подсчёта, поэтому это как бы некие такие
11:07
11 минут 7 секунд
усреднённые показатели. Если мы говорим о повышении количества эритроцитов в крови, мы говорим, что это эритроцитоз. Он может быть первичным.
11:18
11 минут 18 секунд
Это наследственное, тяжёлое, серьёзное заболевание, как правило, о нём знают ещё уже с детства. Ну и вторичный эритроцитоз, с которым нам приходится
11:26
11 минут 26 секунд
сталкиваться чаще. А снижение количества эритроцито в крови называется эритропения. Причины вторичного эритроцитоза, ну, во-первых, может быть,
11:36
11 минут 36 секунд
ограничение жидкости в рационе просто-напросто или очень интенсивные физические нагрузки, сопровождающиеся таким избыточным потоотделением. Это
11:45
11 минут 45 секунд
может быть потеря жидкости, например, на фоне той же неукротимой рвоты, да,
11:49
11 минут 49 секунд
диареи или приёма там диуретиков. Тоже может быть. табакокурение и адаптация к высокогорью,
11:56
11 минут 56 секунд
работа в то же время на глубине могут тоже приводить к эритроцитозу. То есть такие некие состояния гипоксии, да, так
12:03
12 минут 3 секунды
или иначе, они заставляют вырабатывать ну, вырабатываться большему количеству эритроцитов. И мы наблюдаем явление
12:10
12 минут 10 секунд
вторичного эритроцитоза. Тоже мы имеем и при сердечные или лёгочные недостаточности на фоне пороков сердца,
12:17
12 минут 17 секунд
когда имеет место гипоксии. Конечно же,
12:20
12 минут 20 секунд
на это реагирует сразу выработка эритроцитов. Что касается эритропении,
12:26
12 минут 26 секунд
здесь нам приходится с этой ситуацией сталкиваться даже чаще, чем с эритроцитозом. Однозначно эритропени может указывать нам на некие дефициты,
12:36
12 минут 36 секунд
да, и в первую очередь это дефицит железа, дефицит витаминов B12 и B9 фолиевой кислоты, но и на такие заболевания, как тот же гипотиреоз,
12:45
12 минут 45 секунд
цироз печени, хронические болезни почек.
12:48
12 минут 48 секунд
Ну и, конечно же, такие серьёзные заболевания, как поражение костного мозга, в том числе и онкологические, и системные заболевания соединительной
12:57
12 минут 57 секунд
ткани тоже. Если мы говорим об эритроцитах, мы говорим о том, что их основная функция -
13:03
13 минут 3 секунды
это, конечно же, дыхательная, да, это транспорт, это доставка кислорода каждой клеточке нашего тела. Каждый эритроцит
13:12
13 минут 12 секунд
содержит в себе гемоглобин, да? Это как раз вот тот а белок, который содержит себе четыре атома железа, к которым
13:20
13 минут 20 секунд
присоединяются молекулы кислорода. И таким образом он переносит этот кислород каждой клеточке. Конечно же, говоря об
13:27

13 минут 27 секунд
эритроцитах, не сказать о гемоглобине будет совершенно неправильно. Повышение уровня гемоглобина мы также наблюдаем опять же при табакокурении. Вот смотрите, если длительный стаж курения,
13:38
13 минут 38 секунд
очень часто будет высокий гемоглобин и высокие эритроциты. Как бы не пугайтесь, это это скорее всего связано с этим. Нахождение также в условиях высокогория.
13:47
13 минут 47 секунд
Ну, конечно, заболевание крови тоже может быть. Интенсивные занятия спортом тоже могут приводить вот к такому повышению уровня гемоглобина. Что касается напротив его снижения, значит,
13:58
13 минут 58 секунд
речь идёт о том, что, скорее всего, это неправильное питание, это дефицит, это недостаток поступления железа. Мы
14:06
14 минут 6 секунд
говорили о том, что он содержит атомы железа, который необходим для нормальной вот такой вот транспортной функции,
14:13
14 минут 13 секунд
дыхательной функции эритроцитов. Почему может не быть железа? Да, это может быть недостаточное поступление, это может
14:20
14 минут 20 секунд
быть повышенные потери и это может быть повышенный расход. То есть вот здесь вот надо понимать, там недостаточное всасывание, то есть куда теряется это
14:29
14 минут 29 секунд
железо, если это действительно истинный дефицит железа. Надо выяснить, что это, да, неправильное питание, там, не знаю,
14:36
14 минут 36 секунд
устражайшее голодание, вегетарианство,
14:39
14 минут 39 секунд
заболевание органов желудочной кишечным трак, то есть он не всасывается, не усваивается, либо это действительно
14:46
14 минут 46 секунд
кровопотеря, когда он теряется, либо на фоне хронических заболеваний, воспаления, аутоиммунных заболеваний,
14:53
14 минут 53 секунды
которые тоже могут приводить к снижению уровня гемоглобина. Если мы говорим об гематокрите, мы уже немного с вами
15:01
15 минут 1 секунда
сказали, да, это отношение суммарного объёма форменных элементов к общему объёму. Соответственно, если мы имеем дело с эритропениеей, да, когда мало
15:10
15 минут 10 секунд
эритроцитов, да, мы говорим, что основной пулклеток - это эритроциты, то,
15:14
15 минут 14 секунд
конечно же, на этом фоне будет снижен гематокрит. И на фоне всех видов анемии он действительно будет снижен. Но прошу
15:21
15 минут 21 секунда
и как бы призываю ориентироваться не только и не столько на количество эритроцитов, сколько на их ещё и такие цветовые показатели, то есть и размеры,
15:31
15 минут 31 секунда
безусловно. То есть мы можем, нам это обычно пишет лаборатория, да, нормальные размеры или микроцитоз, то есть уменьшенные размеры или, напротив,
15:41
15 минут 41 секунда
макроцитоз, огромные размеры эритроцитов, ну и далее насыщенность цветом. Нам очень важно обратить внимание не только на размер, но и на
15:49
15 минут 49 секунд
насыщенность цветом, которая определяется содержанием гемоглобина в эритроците. Соответственно, если
15:56
15 минут 56 секунд

содержание гемоглобина снижено, то мы увидим гипохромию, то есть такие бледные эритроциты. И напротив, когда она это на
16:05
16 минут 5 секунд
повышено содержание гемоглобинова, а большие эритроциты - это будет гиперхромия. И ещё такой показатель, как
16:12
16 минут 12 секунд
индекс распределения эритроцитов, тоже очень важно. Он всегда повышается при дефиците железа. Ну вот это нормальный
16:20
16 минут 20 секунд
профиль, да, вот это нормацитарной анемии, а вот микроцитарная анемии. То есть они мы имеем место, мы имеем дело с
16:28
16 минут 28 секунд
микроцитозом и гипохромией. Первый признак железодефицита. Напротив,
16:34
16 минут 34 секунды
макроцитоз и гиперхромия нам будут указывать на анемию, связанную с дефицитом B12 или фолиеводефицитную анемию. Ну вот как бы,
16:44
16 минут 44 секунды
чтобы мы с вами, да, понимали, о чём идёт речь. То есть просто схематично по размерам это может быть нормоцитоз,
16:50
16 минут 50 секунд
микроцитоз и макроцитоз. По окраске, по своей цветовой насыщенности, это нормохрамии, гипо и гиперхрамия. Ну и
16:59
16 минут 59 секунд
здесь пойкелацитоз - это изменение формы эритроцитов. Очень неблагоприятный признак, прогностический признак, когда
17:06
17 минут 6 секунд
меняется форма эритроцитов - это плохой признак.
17:10
17 минут 10 секунд
Гипохромия. Мы уже и гиперхромия уже немножечко коснулись причины. Основная причина гипохромии и микроцитоза - это
17:18
17 минут 18 секунд
дефицит железа. Опять же, ищите, откуда она, это дефии, это неправильное питание, это кровопотери, это нарушение
17:26
17 минут 26 секунд
всасывания, куда оно как бы от где причины его потери. операции на желудочно-кишечном тракте, безусловно, и
17:34
17 минут 34 секунды
период быстрого роста тоже может сопровождаться вот такой вот гипохромия,
17:38
17 минут 38 секунд
микроцито, то есть состоянием желездефицита. Аномиих хронических заболеваний тоже могут быть причиной именно гипохромии и микроцитоза. Ну и такие серьёзные заболевания крови, как,
17:50
17 минут 50 секунд
например, таласемия, она связана именно с гемоглобинопатией, да? То есть здесь целое такое, это такое очень серьёзное заболевание. Гиперхромия и макроцитоз -
18:00
18 минут
это, в первую очередь, дефицит витамина B12, дефицит фолиевой кислоты. Дефицит витамина B12 очень часто иммунный
18:07
18 минут 7 секунд
гастрит и гельментозы тоже встречается и может быть причиной, а, ну, опять же, голодание, операции на желудке,
18:14
18 минут 14 секунд
заболевание кишечника, то есть тоже нарушено всасывание этих витаминов. B9,
18:18
18 минут 18 секунд
дефицит полиевой кислоты очень часто встречается у алкоголиков, у лиц,
18:22
18 минут 22 секунды
злоупотребляющих алкоголем, тоже может быть. Ну, на фоне беременности, да.
18:26
18 минут 26 секунд

Почему мы просим вот именно, чтобы В9 именно восполнялась при беременности в первую очередь? Потому что очень часто влияет на пороки нервной трубки. Поэтому
18:34
18 минут 34 секунды
мы очень просим, чтобы именно В9 как бы было достаточным поступлением во время беременности. Ну, заболевание печени,
18:41
18 минут 41 секунда
щитовидной железы тоже могут привести к такой гиперхромий, макроцитозу. Ну и,
18:46
18 минут 46 секунд
конечно же, заболевание крови. Если мы говорим об эритроцитах и гемоглобине,
18:51
18 минут 51 секунда
конечно же, таким образом я подвожу вас к диагностике анемии, потому что именно по этим показателям, ну, скажем так, с
18:58
18 минут 58 секунд
этих показателей мы начинаем диагностику анемии. Анемия - это очень серьёзный патологический
19:06
19 минут 6 секунд
клиникогематологический синдром, который как раз и сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов.
19:13
19 минут 13 секунд
Естественно, нарушается транспорт кислорода. органы и ткани испытывают гипоксию. Что такое, да, прогрессирующая
19:21
19 минут 21 секунда
гипоксия? Особенно с учётом наших возрастных пациентов, да, когда мы или клиентов, когда они не дополучают
19:29
19 минут 29 секунд
кислород, а представьте себе, это головной мозг, а представьте себе это сердце. И, конечно же, в условиях анемии все эти состояния ещё больше усугубляются. Это, конечно же,
19:39
19 минут 39 секунд
обязательно нужно выявлять, и это обязательно нужно с этим, да, это диагностировать, и с этим нужно
19:46
19 минут 46 секунд
бороться. То есть те симптомы, с которыми они к нам могут прийти, это же усталость, слабость, это бледность кожных покровов, видимых слизистых,
19:54
19 минут 54 секунды
головокружение, головная боль, тахикардия, ломкости и выпадения волос,
19:59
19 минут 59 секунд
ногтевая дистрофия. Конечно же, это всё те симптомы, которые позволяют заподозрить какое-то, да, вот такое вот
20:06
20 минут 6 секунд
состояние анемичное. В случае, если мы это пропускаем, то это всё осложняется прогрессирующей гипоксией тканей и органов. То, что я говорила, да,
20:15
20 минут 15 секунд
нагрузка в том числе на сердце. А представьте себе, если это уже сосуды,
20:19
20 минут 19 секунд
поражённые атеросклерозом, в том числе и сосуды головного мозга, и сосуды сердца,
20:24
20 минут 24 секунды
там как бы много не надо. И вот эта анемия, та же гипоксия, конечно же, всё приводит, в том числе и к ослаблению
20:31
20 минут 31 секунда
иммунной системы и в дальнейшем может привести и к смертельному исходу. Если мы говорим о состоянии желездефицита, на
20:39
20 минут 39 секунд
сегодня это действительно очень частое состояние, которое мы диагностируем.
20:43
20 минут 43 секунды

Особенно даже не железодефицитной, уже даже латентный железодефицит. Мы проговорим с вами эти понятия. Ну, в
20:51
20 минут 51 секунда
случае с железодефицитной анемии, в общем-то, всё понятно. И посмотрите, до 80% всех анеми взрослых составляет
20:58
20 минут 58 секунд
именно железодефицитная анемия. Но с другой стороны, вы скажете, в чём проблема диагностировать железодефицитную анемию, если мы можем
21:05
21 минута 5 секунд
определить показатель железа, да, в крови, и нам всё станет ясно. Но здесь немножечко тоже не всё так однозначно,
21:13
21 минута 13 секунд
потому что железо это как бы то отражает железо, которое находится в плаз, в кровотоке. Ну, есть некие нормы, конечно
21:21
21 минута 21 секунда
же, мы посмотрим на них. Если у нас идёт явное железодефицитной анемии, мы,
21:25
21 минута 25 секунд
конечно же, увидим сниженные цифры железа. Но есть такие показатели, на которые мы обязательно должны обращать
21:32
21 минута 32 секунды
внимание и которые нам уже будут сигнализировать о железодефиците даже в отсутствии анемии. То есть гемоглобин,
21:39
21 минута 39 секунд
эритроциты, они ещё не снизятся, но запасы железа, а это за это отвечает такой показатель, как феритин, будут нам показывать, что здесь уже есть проблема.
21:51
21 минута 51 секунда
И в железо здесь надо восполнять. То есть феритин он снижается задолго до развития анемии. Он показатель именно
21:59
21 минута 59 секунд
вот таких тканевых депо железа. То есть отражает запасы железа. Это именно вот этот феритин, да, тоже сегодня очень
22:07
22 минуты 7 секунд
известный белок, о котором мы тоже всё знаем и много говорим. Но обратите внимание, это тоже может быть. Здесь тоже есть, скажем так, подводные камни,
22:16
22 минуты 16 секунд
потому что феритин может обманчиво быть повышен. И если мы увидим, что феритин повышен, ну и мы успокоимся, понимая,
22:24
22 минуты 24 секунды
да, ну раз феритин повышен, значит, ой, сколько железа в депо. Нет, феритин - это ещё и белок острой фазы воспаления.
22:32
22 минуты 32 секунды
Это очень серьёзный белок, который отвечает тут же на любой аутоиммунный воспалительный процесс, на хронические
22:40
22 минуты 40 секунд
заболевания. Он он будет повышен. И вот это может вас немножечко как бы смутить.
22:46
22 минуты 46 секунд
Помните об этом. Помните, что он маркёр воспаления, повышен может быть при воспалительных процессах, но при этом это совершенно не исключает железо
22:55
22 минуты 55 секунд
дефицит. Значит, давайте найдём те маркёры, которые не будут реагировать на воспаление и будут нам чётко, скажем так, характеризовать обмен железа.
23:05
23 минуты 5 секунд
Поэтому, если мы видим повышенный феритин, а при этом всё как бы сходится сводится к тому, что это всё же железодефицит, давайте мы попробуем
23:14
23 минуты 14 секунд
дообследовать, да, то есть тот же С реактивный белок, это сразу же покажет нам: "Ой, да он там он в норме всегда до пяти, да, тут, например, и 15, и бывает
23:23

23 минуты 23 секунды
и 150". То есть здесь явно идёт воспалительный процесс. И, скорее всего,
23:28
23 минуты 28 секунд
вот такая анемия, она не истина железодефицитная, а это анемия хронических заболеваний. Но сначала
23:35
23 минуты 35 секунд
нужно ещё дальше дообследовать. Не забывайте о том, что есть такой белок,
23:39
23 минуты 39 секунд
как трансферин. Это плазменный белок. Он синтезируется в печени, и он как бы основной переносчик железа от места его
23:47
23 минуты 47 секунд
всасывания до, то есть в тонком кишечнике до того места, где он должен использоваться. То есть это костный мозг, печень и селезёнка. Если же
23:56
23 минуты 56 секунд
количество железа недостаточное, то печень начинает вырабатывать много трансферина, дабы он мог уловить хотя бы самые малюсенькие кусочки железа.
24:06
24 минуты 6 секунд
Поэтому как бы увеличивается общая железовающая способность сыворотки,
24:11
24 минуты 11 секунд
увеличивается трансферин. Вот его будет много. И он не зависит ни от воспаления, ни от каких-то пристино желездефиците.
24:19
24 минуты 19 секунд
трансферина становится много, и он пытается уловить хотя бы малюсенькие частички железа, но при этом процент его
24:27
24 минуты 27 секунд
насыщение, вот ещё второй очень важный показатель, да, трансферин и процент насыщения трансфери железа, он будет
24:35
24 минуты 35 секунд
снижен, потому что он не может в полной мере насытиться железом. Его просто нет.
24:39
24 минуты 39 секунд
Ухватить он ухватил, но совсем малюсенькое количество, поэтому процент насыщений будет снижен. То есть, ещё
24:47
24 минуты 47 секунд
раз, феритин, если это истинный железо дефицит, он будет тоже снижен. Если же он повышен, то давайте исключать или
24:54
24 минуты 54 секунды
подтверждать железодефицит тем, что мы возьмём трансферин и возьмём процент насыщения трансферина железа. Есть ещё такие растворимые рецепторы трансферина.
25:04
25 минут 4 секунды
Это тоже такой анализ тоже проводится. И он тоже может указывать нам на истинный такой желездефицит. Ну, давайте пока для начала, да, трансферин повышается,
25:14
25 минут 14 секунд
процент насыщения трансферина железом снижается при железофиците. То есть, если мы уже
25:22
25 минут 22 секунды
столкнулись как бы с самым таким латентным железодефицитом, когда ещё может не быть в анализе никаких
25:29
25 минут 29 секунд
признаков анемии, вот такой скрытый или латентный дефицит, он тоже не должен пропускаться, потому что так или иначе
25:36
25 минут 36 секунд
он перейдёт потом в явную железодефицитную анемию. Но зачем нам это, если мы можем повлиять уже на начальные проявление желездефицита, на
25:45
25 минут 45 секунд
латентный или скрытый железодефицит? То есть это снижение уровня феритина,
25:49
25 минут 49 секунд
повышение трансферина и снижение процента насыщения трансферина железом.

25:54
25 минут 54 секунды
Вот это, наверное, основные такие проявления латентного железодефицита. В случае с желездефицитной анемии здесь будет всё понятно, как бы тут уже будут явные признаки анемии: гипохромия,
26:06
26 минут 6 секунд
микроцитоз, снижение гемоглобина, снижение эритроцитов, снижение феритина.
26:11
26 минут 11 секунд
Здесь уже будет как бы такая явная железодефицитная анемия. Ну и вот в отличие, да, от той же анемии
26:17
26 минут 17 секунд
хронических заболеваний, вот это тоже обязательно, это как бы на втором месте по распространённости, которая очень
26:25
26 минут 25 секунд
часто сопровождает такие тяжёлые хронические заболевания, в том числе и аутоиммунные заболевания. Вот на этом
26:33
26 минут 33 секунды
фоне перетин будет высоким. Вот на это и будут все другие маркёры воспаления. Вот что будет отличительным
26:41
26 минут 41 секунда
признаком, то, что будут повышены все маркёры воспалительного процесса. Ну и,
26:46
26 минут 46 секунд
конечно же, будет какой-то очаг или хроническое заболевание. Ещё на какой показатель обязательно обращать внимание - это скорость оседания эритроцита. Вот это тоже очень важный показатель.
26:56
26 минут 56 секунд
Никогда не встречала его снижение,
26:59
26 минут 59 секунд
честно говоря. А вот повышение очень часто указывает нам в первую очередь на воспалительные заболевания, на
27:06
27 минут 6 секунд
онкологические заболевания, на ревматические заболевания, на заболевание крови. Обратите внимание,
27:12
27 минут 12 секунд
при анемии тоже может наблюдаться повышение скорости оседания эритроцитов,
27:18
27 минут 18 секунд
соя, да, а голодание, там различные виды очень строгого соблюдения разных постов,
27:23
27 минут 23 секунды
да, то есть это очень тоже такое всё может влиять в том числе и на соль.
27:28
27 минут 28 секунд
Гипотиреоз и тиреотоксикоз тоже, то есть дисфункция щитовидной железы,
27:33
27 минут 33 секунды
расстройства обмена веществ могут увеличивать соль. Лейкоциты. Лейкоциты мы все знаем, наверное, ещё из биологии.
27:40
27 минут 40 секунд
Это те клетки, которые выполняют защитные функции, да, это обеспечение клеточного и гуморального иммунитета. Но они представлены разными клетками,
27:49
27 минут 49 секунд
разные виды клеток отвечают за свою там за свою функцию и представляют свою функцию. Они иногда спрашивают: "Да, вам общий анализ развёрнутый?" Да,
27:59
27 минут 59 секунд
развёрнутый с лейкоцитарной формулой. То есть мы видим как бы их такую разграничение по процентному соотношению. Это очень важно. Значит,
28:08
28 минут 8 секунд
среди этого мы различаем как бы среди лейкоцитов мы различаем гранулациты, которые представлены нейтрофилами,
28:14
28 минут 14 секунд

эузинофилами и базофилами и агронулациты, лимфоциты и моноциты. нейтрофилы - это, в первую очередь,
28:22
28 минут 22 секунды
противобактериальный, противораковый, ну, в первую очередь, наверное,
28:24
28 минут 24 секунды
противобактериальный иммунитет при любых, аэ, бактериальных инфекциях, вот когда пишут, да, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, это значит, за счёт вот
28:33
28 минут 33 секунды
этих молодых нейтрофилов начинается борьба, активная борьба с инфекцией.
28:38
28 минут 38 секунд
Конечно, будет повышен уровень самих лейкоцитов за счёт фракции нейтрофилов.
28:43
28 минут 43 секунды
Сразу говорю, смотрите, не столько на процентное соотношение, сколько на абсолютное содержание. Иногда это задаёт вопрос: "Ой, вот тут вот, я не знаю,
28:52
28 минут 52 секунды
нейтрофил на 0 за 2% 0,02. Ну и что? Это клинически незначимо. Скорее всего,
29:00
29 минут
обязательно нужно переводить в абсолютные цифры и уже о более серьёзных там каких-то проблемах судить по абсолютным цифрам, но не по процентному
29:09
29 минут 9 секунд
соотношению. Эузинофилы. Мы знаем, что это всегда реакция, в первую очередь аллергическая, да, там атопические дерматиты, бронхиальная астма, экзема,
29:18
29 минут 18 секунд
всегда ответит повышением эузинофилов.
29:21
29 минут 21 секунда
Это тоже обязательно помните. Но и ещё ситуация, при которой мы будем видеть повышенное количество эзинофилов - это
29:27
29 минут 27 секунд
паразитозы. Поэтому тоже об этом не забывайте. Базофилы тоже аллергические реакции. Лимфоциты и моноциты, как бы их
29:36
29 минут 36 секунд
абсолютное повышение говорит в первую очередь о вирусной инфекции. То есть очень часто мне приносят анализы тут, ну
29:43
29 минут 43 секунды
явно что случилось тут с тримфаци? Ну это вы, наверное, болели, ну это даже какой-то OPV, да, был. Пускай вы чтобы болели, да, но явно у вас ответ идёт там
29:52
29 минут 52 секунды
нейтропения, то есть мало нейтрофил, но за счёт лимфоцитов и моноцитов увеличит как бы пул этих клеток. Значит,
30:00
30 минут
лимфоциты, им моноциты, в первую очередь борьба с вирусной инфекцией, нейтрофилы,
30:04
30 минут 4 секунды
ну и в целом количество лейкоцитов. В первую очередь ответ на, а,
30:09
30 минут 9 секунд
антибактериальная такая защита. Ну и вот как раз вот этот вот распределение их по процентам, но ещё раз повторюсь,
30:15
30 минут 15 секунд
обязательно пересчитывать, если есть какие-то изменения, в абсолютное значения, и вы вообще можете не выйти ни
30:22
30 минут 22 секунды
на какие изменения. Сдвиг лицитарной формулы влево. Повторюсь, это значит вот такая вот именно борьба идёт с инфекцией
30:30
30 минут 30 секунд
в первую очередь при инфекционных, при воспалительных процессах. Сдвигли кацитарной формулы вправо. Наоборот,

30:35
30 минут 35 секунд
появление таких старых уже сегмента ядерных нейтрофилов. Это очень часто бывает при В12 дефицитной анемии. Прямо пишет сдвиг лекоцитарной формулы вправо.
30:45
30 минут 45 секунд
Недостаток опять же фолиевой кислоты.
30:48
30 минут 48 секунд
Прихол, да, хроническо обструктивной болезни лёгких тоже может быть при болезни почек и печени. Что касается
30:55
30 минут 55 секунд
тромбоцитов, да, мы не считаем их как бы клетками крови. Мы говорим, что это кровяные пластинки, в них нет ядра или как бы клеточные фрагменты, как хотите.
31:04
31 минута 4 секунды
Это не истинно клеточное образование, но у них очень важная функция, да, это свёртываемость крови. Они обеспечивают
31:12
31 минута 12 секунд
свёртываемость, они обеспечивают формирование тромботического сгустка, они инициируют репарацию тканей,
31:19
31 минута 19 секунд
регулируя вот эту вот местную воспалительную реакцию. Поэтому, конечно же, от количества тромбоцитов, да, если это повышенное количество тромбоцитоз,
31:29
31 минута 29 секунд
пониженное количество тромбоцита пения,
31:32
31 минута 32 секунды
тоже могут быть разные причины. В то же время та, вернее, избыточная физическая нагрузка может приводить к тромбоцитозу,
31:39
31 минута 39 секунд
анемия. Помните о том, что анемия может сопровождаться таким вот реактивным тромбоцитозом. воспалительные процессы,
31:47
31 минута 47 секунд
онкологические заболевания, болезни крови, травмы, операции, чрезмерное употребление алкоголя тоже может приводить к некоторому тромбоцитозу. А
31:56
31 минута 56 секунд
тромбоцитопения в первую очередь обязательно поинтересуйтесь, не принимают ли они, например,
32:00
32 минуты
антикоагулянты, да, которые могут снижать количество тромбоцитов, гиперсплинизм, цирроз печени, заболевания щитовидной железы,
32:08
32 минуты 8 секунд
заболевания крови, вирусные заболевания тоже могут сопровождаться уменьшением количества тромбоцитов крови. Если мы
32:16
32 минуты 16 секунд
проговорили с вами сейчас общий анализ крови, то теперь я немножечко проговорю о биохимическом анализе крови. Я не
32:24
32 минуты 24 секунды
сторонница, сразу говорю, вот такого огульного вот очень множественного назначения различных компонентов биохимического анализа крови. Нет,
32:33
32 минуты 33 секунды
абсолютно. Потому что зачастую ты даже просто сам не знаешь, как это интерпретировать, да? Не нужно этого делать, потому что пациенты или клиенты,
32:43
32 минуты 43 секунды
да, они бывают совершенно разные, они бывают мнительные, они бывают тревожные.
32:48
32 минуты 48 секунд
и какое-то там микроскопическое увеличение того или иного компонента,

32:51
32 минуты 51 секунда
который вообще не как бы, ну, вообще клинически незначимо, может повергнуть их вот в такое состояние паники. Поэтому
32:58
32 минуты 58 секунд
есть как бы основные показатели, на которые мы должны обязательно ориентироваться. Вот их я буду, конечно же, рекомендовать каждому, да, там будь
33:07
33 минуты 7 секунд
кто в рамках чекапа или это просто обследование пациента по либо там по каким-то жалобам, да, определённым. Но есть такие показатели, как общий белок,
33:16
33 минуты 16 секунд
то есть показатели белкового обмена,
33:18
33 минуты 18 секунд
углеводного обмена, показатели жирового обмена липидограма, показатель работы печени, да, это ферменты печени, белерубин,
33:26
33 минуты 26 секунд
креатинин, мочевина, мочевая кислота -
33:28
33 минуты 28 секунд
это почки. Ну и такие микроэлементы. Я несколько слов об этом скажу. Опять же,
33:33
33 минуты 33 секунды
я против микроэлементов масса и макро, и микроэлементов, но есть как бы определённы это как бы калий натрий хлор - это определённый этот, ну, скажем так,
33:41
33 минуты 41 секунда
тройка, да, вот этих микроэлементов,
33:43
33 минуты 43 секунды
которые мы, как правило, используем в биохимическом анализе. Общий белок очень важный элемент, да, мы, скажем так,
33:50
33 минуты 50 секунд
когда с немножечко позволит себе такое лирическое отступление, когда впервые биохивестный открыл белок, это был там
33:58
33 минуты 58 секунд
1800, по-моему, тридцать четвё. Вот тогда он впервые написал, что я так и знал, что есть вещество, без которого
34:06
34 минуты 6 секунд
невозможно жизнь, зарождение жизни на планете. Это вещество - это белок. То есть без белка невозможно в целом жизни.
34:14
34 минуты 14 секунд
Поэтому, конечно же, на этот показатель обращать обязательно внимание. Обращать внимание на состояние гиперпротеиными
34:23
34 минуты 23 секунды
редко, но тоже бывает. Чаще мы сталкиваемся, конечно, с гипопротеинами, но состояние гиперпротеинами - это,
34:29
34 минуты 29 секунд
скорее всего, на фоне такой гемоконцентрации, например, там обезвоживание, да, или недостаточный приём жидкости, какие-то тоже
34:37
34 минуты 37 секунд
хронические воспаления, опухоли системы кроветния, в первую очередь миломная болезнь. А вот гипопротеинемия, с этим мы сталкиваемся чаще.
34:48
34 минуты 48 секунд
Причина чаще - это недостаточное поступление, потому что белок, как правило, мы получаем с пищи, да, белок -
34:54
34 минуты 54 секунды
это обязательный компонент, постоянно идёт, постоянно идёт обмен белка, он распадается и на аминокислоты, да, и вот тот порядок аминокислот, который, а,
35:05
35 минут 5 секунд

скажем так, да, сохранён в нашей ДНК,
35:07
35 минут 7 секунд
вот именно та последовательность аминокислот формирует наши собственные белки, из которых как бы состоит, ну, вообще каждая клеточка нашего тела.
35:15
35 минут 15 секунд
Поэтому, конечно же, недостаточное его поступление, в основном он поступает именно с пищей, или неправильное,
35:22
35 минут 22 секунды
несбалансированное питание на фоне голодание, это вегетарианство, это стражайшие диеты. Вот вам выход
35:30
35 минут 30 секунд
гипопротеинами. Но это может быть и недостаточное усвоение, да, на фоне,
35:34
35 минут 34 секунды
например, тех же заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Это могут быть потери белка с мочой на фоне заболевания почек, хронические
35:42
35 минут 42 секунды
кровотечения, усиленный распад белка при лихорадке, при интоксикации, либо нарушении процессов биосинтеза.
35:49
35 минут 49 секунд
Биосинтез белка идёт в печени, поэтому любое поражение печени, цирроз, гепатит тоже может нарушать нормальный синтез белка и приводить к гипопротеинами.
36:00
36 минут
Если мы смотрим, как правило, на общий э общий белок, как бы на концентрацию общего белка, и оно в нормальных пределах, как бы здесь можно,
36:09
36 минут 9 секунд
в принципе, успокоиться, посмотреть,
36:10
36 минут 10 секунд
если у вас там какие-то сомнения или что. Как правило, производят расчёт различных фракций белковых, да? Мы говорим о том, что основные две фракции
36:19
36 минут 19 секунд
- это альбумины и глобулины и их соотношение. Вот это соотношение может выявить диспротонемию. Это, как правило,
36:27
36 минут 27 секунд
ну, назначается, повторюсь, в каких-то различных ситуациях не так, чтобы всем подряд, ну, в случае какой-то там
36:34
36 минут 34 секунды
воспалительных процессов или вы подозреваете, там аутоиммунные,
36:38
36 минут 38 секунд
онкологические процессы можно подсчитать отдельно и рассчитать фракции альбуминов и глобулин и как бы их соотношение. Вот
36:46
36 минут 46 секунд
альбумины, они занимают до 60% всех белков именно альбумины. У них две главные функции - это распределение воды внутри организма. как бы они не дают, а,
36:55
36 минут 55 секунд
этой воде просачиваться, да, сквозь стенки сосудов, удерживая её внутри сосуда, как бы препятствуя отёком. Но они пере помогают переносить, даже это
37:04
37 минут 4 секунды
транспортная функция, да, эти же витамины, минералы, лекарственные вещества, всё это тоже а делают альбумины. Второй вид белков - это
37:12
37 минут 12 секунд
глобулины. Они делятся на альфа, бета и гаммаглобулины. И тоже можно проверить каждую фракцию, да, иногда просто делают
37:20
37 минут 20 секунд

соотношение альбуминглобулина. можно среди глобулинов провести тоже такой же,
37:25
37 минут 25 секунд
да, а, как это называется, наверное, или там, не знаю, в общем, их всех про в процентах, да, соотношение указать всех этих трёх фракций. А альфаглобулины -
37:36
37 минут 36 секунд
это в первую очередь защита, но не против какого-то конкретного, да, как бы, а в целом защита такая неспецифическая от бактериальной
37:44
37 минут 44 секунды
инфекции. Бетаглобулины - это как раз опять же тоже в том числе и транспортная функция. Они не связывают гормоны,
37:51
37 минут 51 секунда
витамины, минералы тоже доставляют в нужные органы. Отвечают также за свёртываемость крови. Ну и гаммоглобулины, да, это тоже всем
37:59
37 минут 59 секунд
известные нам антитела, которые отвечают за все иммунные ответы в организме, за иммунные процессы, передаются от матери
38:07
38 минут 7 секунд
к новорождённому, обеспечивают первичный иммунитет и противопаразитарные формирование местного иммунитета,
38:14
38 минут 14 секунд
иммуномодуляторы. Это вот как раз фракция гаммоглобулина. Это что касается белкового обмена.
38:21
38 минут 21 секунда
Теперь нарушение углеводного обмена. Да, здесь я, к сожалению, должна сказать,
38:26
38 минут 26 секунд
что очень утешительная статистика, в том числе и по России. Каждый четвёртый житель России имеет то или иное нарушение углеводного обмена. Это,
38:34
38 минут 34 секунды
конечно же, очень печально. Сахарный диабет. Сегодня говорить я буду именно о сахарном диабете второго типа, да? Если
38:42
38 минут 42 секунды
в случае сахарным диабетом первого типа здесь как бы всё понятно. Здесь идёт чистый такой вот, а, дефицит инсулина,
38:48
38 минут 48 секунд
то есть вы нет выработки, абсолютный дефицит инсулина, то в случае с сахарным диабетом второго типа его много. Смысл
38:56
38 минут 56 секунд
инсулина в том, что соединяясь с рецептором, он открывает канал, через который глюкоза поступает в клетку. Что
39:03
39 минут 3 секунды
происходит в случае сахарного диабета второго типа? Мы сталкиваемся с инсулинорезистентностью. Инсулин не
39:10
39 минут 10 секунд
связывается с рецептором, не открывается канал, глюкоза не поступает в клетку.
39:16
39 минут 16 секунд
Чем это чревато? Что клетка не получает достаточного количества глюкозы,
39:20
39 минут 20 секунд
энергии. Она продолжает сигнализировать о том, что ей у неё нет глюкозы, а инсулина вырабатывается ещё больше, а
39:28
39 минут 28 секунд
толку нет, потому что он не может связаться с рецептором. Поэтому вот это возникает как бы два токсических
39:34
39 минут 34 секунды
состояния. это гиперинсулинемия компенсаторная, а с другой стороны гипергликемия по тоже токсическая, тупо
39:42
39 минут 42 секунды
только потому, что глюкоза не может проникнуть в клетку. Поэтому, конечно же, сегодня вот именно сахарный диабет
39:49

39 минут 49 секунд
второго типа, это настоящая эпидемия, а сахарный диабет второго типа абсолютно чётко идёт рука оброку с абдоминальным
39:57
39 минут 57 секунд
ожирением, которое сегодня, ну, тоже просто представляет эпидемии. И есть даже такой термин диабесити. То есть
40:05
40 минут 5 секунд
диабет и обесити, ожирение. Вот это как бы настолько действительно два взаимосвязанных заболевания, которые
40:12
40 минут 12 секунд
сегодня просто представляют эпидемию XXI века. А лабораторная диагностика - это как раз то, с чего начинается нарушение
40:20
40 минут 20 секунд
выявлений углеводного обмена. Ну и вот более 90% людей с нарушенной толерантностью глюкозе вообще могут не подозревать у себя этого состояния.
40:30
40 минут 30 секунд
Нарушение углеводного обмена мы делим на нарушенную толерантность глюкозе,
40:34
40 минут 34 секунды
нарушенную гипергликемию на тощах и сахарный диабет второго типа. Почему мы делаем акцент на раннем выявлении вот таких преддиабетических состояний?
40:43
40 минут 43 секунды
Потому что у нас есть шанс вернуть их к норме. И и нет шанса, если они, как вы видите, у третий людей через 5 лет они
40:53
40 минут 53 секунды
переходят в сахарный диабет. Если есть сочетание уже есть не только с нарушенной толерантностью, но уже нарушенная гипергликемия на тоща, то,
41:01
41 минута 1 секунда
конечно же, сахарный диабет через 5 лет вы видите у подавляющего большинства пациентов в любом случае он перейдёт. Ну и вот более 90% пациентов диабетом второго типа страдают избыточным весом.
41:13
41 минута 13 секунд
Ну и ещё тоже из печального, что истинная распространённость явного сахарного диабета, она ещё и занижена. Она в несколько раз и ой, наоборот,
41:22
41 минута 22 секунды
истинная как бы распространа наоборот превышает регистрируемую. То есть мы то число, что видим, оно заниженное, потому
41:31
41 минута 31 секунда
что до того, как начинают появляться уже осложнения, до того момента, когда они уже к нам приходят, мы, к сожалению,
41:39
41 минута 39 секунд
они, вернее, уже имеют те или иные осложнения. Уже тогда мы говорим о том, что тут,
41:45
41 минута 45 секунд
конечно же, переход уже в состояние сахарного диабета второго типа, тяжёлая хроническое состояние, которое приводит
41:52
41 минута 52 секунды
к таким достаточно серьёзным последствиям. Как диагностировать нарушение углеводного обмена? Ну,
41:58
41 минута 58 секунд
давайте, конечно же, в первую очередь посмотрим глюкозу. Гипогликемии состояние снижения глюкозы плазма. Мы опять же сможем наблюдать при голодании,
42:08
42 минуты 8 секунд
недоедании, там интенсивные физические нагрузки, приём лекарственных препаратов, да, например, тех же гипогликемических, не отредактированные дозы, да, на неоткорректированные дозы,
42:23
42 минуты 23 секунды
гипер гликемии. В первую очередь,
42:26
42 минуты 26 секунд
конечно, нарушение гликемии, там натощак, острый панкреатит, может тоже быть, фиохромоцитома, тиреотоксикоз тоже

42:33
42 минуты 33 секунды
может сохра наблюдаться, а, и протекать с гипергликемии, кроме глюкозы. И мы не только и не столько должны
42:40
42 минуты 40 секунд
ориентироваться на глюкозу, сколько обязательно на гликированный гемоглобин.
42:45
42 минуты 45 секунд
Это обязательно. Почему? Значит, срок жизни эритроцитов составляет до 120 дней. Эритроцит, мы говорили, содержит
42:52
42 минуты 52 секунды
гемоглобин. Если глюкозы много, она начинает присоединяться к этому, к этим эритроцитам, к этому гемоглобину, она
42:59
42 минуты 59 секунд
начинает превращать его в гликированный гемоглобин. Молекула гемоглобина изменяется. Он уже не может выполнять
43:06
43 минуты 6 секунд
нормально, полноценно свою функцию за счёт этого гликированного гемоглобина. Но так как эритроцит живёт, мы говорим,
43:13
43 минуты 13 секунд
до 120 дней, вот именно этот гликированный гемоглобин поможет нам более точно оценить состояние углеводного обмена. То есть, если мы будем ориентироваться только на глюкозу,
43:23
43 минуты 23 секунды
на тощак, это будет неправильно. Потому что сегодня наш клиент, допустим, очень себя контролировал, он ничего не ел, он
43:31
43 минуты 31 секунда
выдержал там такой приличный интервал голодания, и наутро у него может быть нормальным сахар, но он может быть обманчивым, потому что при обычном или
43:39
43 минуты 39 секунд
напротив, да, у него сахар-то нормальный, он просто поел поздно, а тут надо сдать анализ. Поэтому вот эти вот правила соблюдения анализа тоже должны
43:46
43 минуты 46 секунд
быть выдержаны. Но если вы возьмёте и будете ориентироваться ещё и на гликированный гемоглобин, здесь вам всё станет больше более ясно, потому что это
43:55
43 минуты 55 секунд
действительно тот интегральный показатель углеводного обмена за 3 месяца. Это показатель и не только выявления диабета, но и показатель
44:03
44 минуты 3 секунды
компенсации сахарного диабета. Поэтому это тот показатель, который сегодня действительно рекомендован экспертами
44:10
44 минуты 10 секунд
ВОЗ для определения и диагностики сахарного диабета. Вот цифра гликированного гемоглобина. Верхняя его граница - это 6,5. Если мы говорим, что
44:19
44 минуты 19 секунд
больше 6,5- это сахарный диабет здесь нет сомнений. Если мы говорим, что немного ниже, мы ещё не успокаиваемся,
44:26
44 минуты 26 секунд
что это норма, потому что от 5 до 6,4 серая зона. Если попадаем в эту серую
44:33
44 минуты 33 секунды
зону, обязательно исключать преддиабетические состояния, то есть тоже нарушение толерантности глюкозе,
44:40
44 минуты 40 секунд
да. Для этого мы проводим пероральный глюкозотолерантный тест. И, конечно же,
44:45
44 минуты 45 секунд
это может быть и нарушение гипергликемии на тощак. То есть обязательно посмотреть, это просто вот такие вот ранние такие проявления, как бы
44:53
44 минуты 53 секунды

преддиабетические состояния или это уже более серьёзные заболевания. Поэтому вот эта вот серая зона у вас тоже должна быть всегда в голове. Что касается
45:02
45 минут 2 секунды
лепидограмы, да, липидограммы к ней я вообще как бы отношусь, так сказать, с неким трепетом, потому что, да, по своей специальности я первую очередь кардиолог и врач функциональной диагностики,
45:13
45 минут 13 секунд
ультразвуковой диагностики. Для меня этот показатель, показатели этого анализа, да, это не просто цифры, это риск сердечно-сосудистых заболеваний.
45:24
45 минут 24 секунды
Поэтому я очень, я сейчас покажу ей общие развёрнутые липедограммы, на какие показатели нужно обязательно обращать
45:32
45 минут 32 секунды
внимание, потому что, повторюсь, именно по этим цифрам мы рассчитываем риск сердечно-сосудистых заболевания. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что сердечно-сосудистые заболевания,
45:43
45 минут 43 секунды
несмотря на все наши усилия, продолжают лидировать печальной статистике, общей статистике и смертности, и
45:51
45 минут 51 секунда
заболеваемости. И первое место в структуре сердечно-сосудистых заболеваний занимает именно ишемическая
45:59
45 минут 59 секунд
болезнь сердца. А её этиология, её первопричина - это атеросклероз коронарных артерий. Что такое атеросклероз? Это отложение бляшек
46:08
46 минут 8 секунд
атеросклеротических, которые закрывают просвет сосудов, которые нарушают нормальное кровоснабжение сердца. И что
46:15
46 минут 15 секунд
самое, скажем так, печальное, да, что устранение вот этих факторов риска способно предупредить до 8%
46:24
46 минут 24 секунды
сердечно-сосудистых событий. Это, в первую очередь, да, те же инфаркты. Поэтому мы можем это предупредить,
46:30
46 минут 30 секунд
потому что мы знаем, что есть та же липидная теория, да, когда проникая в толщи сосудов, начинает формироваться бляшка, проникает именно холестерин,
46:40
46 минут 40 секунд
холестерин атерогенный, потому что мы видим, да, в липидограме есть несколько фракций. И общий холестерин, он представлен в большей степени
46:49
46 минут 49 секунд
липопротеидами низкой плотности. Вот низкая плотность, очень низкая и промежуточная плотность - это как раз холестерин, как мы говорим, плохой, да,
46:58
46 минут 58 секунд
или атерогенный холестерин. Это именно те цифры, которые определяют риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний в целом.
47:08
47 минут 8 секунд
Поэтому не смотрите на холестерин, допустим, пять, и вы успокоитесь, да,
47:12
47 минут 12 секунд
всё прекрасно, но у него ниже, ну, как бы в пределах нормы, пусть там на верхней границе. Смотрите на липопротеиды низкой плотности, потому
47:20
47 минут 20 секунд
что они могут быть повышены. Вот нужно обязательно определять именно фракции холестерина. Почему я всегда пишу, да,
47:27
47 минут 27 секунд
об там холестерин и его фракции. Это очень важно. Либо протеиды высокой плотности, напротив, это более, скажем
47:35
47 минут 35 секунд

так, ну, как говорится, да, хороший холестерин с таким более благоприятным действием, потому что он обладает антиатерогенными фракциями,
47:43
47 минут 43 секунды
антиатерогенными факторами, да,
47:45
47 минут 45 секунд
способностями. Но, к сожалению, его очень часто бывает низко, его уровень как раз снижен за счёт повышения
47:52
47 минут 52 секунды
липопротеидов низкой плотности. Три глицерида - это ещё одна фракция тоже, которую мы оцениваем в липидограмме.
48:00
48 минут
Очень часто их повышенный уровень ассоциирован с диабетом, очень часто с ожирением, с артериальной гипертензией.
48:07
48 минут 7 секунд
Вот вы при очень они бывают кратно повышены, то есть при норме до 1,7 бывает и 129. То есть для них это вообще
48:15
48 минут 15 секунд
нормальный цифр, то это, конечно, очень высоко, потому что это тоже атерогенная частица. Ну и при высоком уровне триглицеридов всегда повышены риск
48:23
48 минут 23 секунды
панкреатита. Ну и вот здесь как бы я тоже дала такие, это абсолютно усреднённые значения. Это значение для
48:30
48 минут 30 секунд
условно здорового человека, человека без факторов риска. Но мы говорим о возрастовисимых заболеваниях. И, как правило, очень часто это уже
48:39
48 минут 39 секунд
коморбидность, то есть это и артериальная гипертония, и, допустим,
48:42
48 минут 42 секунды
ишемическая болезнь сердца. то для них эти показатели будут гораздо жёстче. И здесь, говоря о липидограме, да, мы
48:49
48 минут 49 секунд
говорим о целевых значениях. И вот эта липопротеида низкой плотности значение меньше трёх, это говорит лишь о, а лицах
48:58
48 минут 58 секунд
с самым низким уровнем риска. Если это уже пациенты с перенесённым инфарктом,
49:03
49 минут 3 секунды
там, с диагностицированной ишемической болезнью, для них это показатели меньше 1,8, а для очень высокого риска ниже
49:10
49 минут 10 секунд
1,4. То есть вот это показатели, к которым нужно стремиться. То есть я к тому, что обязательно оценивайте
49:18
49 минут 18 секунд
всесторонне и не смотрите только на цифры, но и рассчитывайте и сразу предполагайте риск сердечно-сосудистых
49:26
49 минут 26 секунд
заболеваний у наших клиентов. И если вы видите коэффициент атерогенности, на самом деле даже больше меньше трёх, вот такой должен быть в норме. А мы на него,
49:35
49 минут 35 секунд
как правило, ориентируемся. Это тоже сейчас стал рассчитывать. Раньше мы его рассчитывали вручную. Сейчас это тоже дают лаборатории. И вот повышенные это
49:43
49 минут 43 секунды
как бы соотношение, скажем так, плохих и хорошего холестерина, фракций вот этих,
49:48
49 минут 48 секунд
да. И если мы говорим о коэффициенте атерогенности больше трёх, вот так, грубо говоря, то мы говорим, что здесь,
49:55
49 минут 55 секунд
скорее всего, очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ещё раз, да, есть липидный профиль- это общий холестерин, три глицериды,

50:02
50 минут 2 секунды
холестерин либопротеида высокой, низкой плотности. И что ещё сегодня используется? Это холестерин.
50:10
50 минут 10 секунд
нелипопротеидов высокой плотности. Вот так прямо называется. Это холестерин,
50:14
50 минут 14 секунд
который содержит только оттерогенной фракции, то есть за вычетом холестерина,
50:19
50 минут 19 секунд
липопротеидов высокой плотности, то есть от арогенное фракции. Ну и ещё сразу скажу, есть такой расширенный анализ,
50:25
50 минут 25 секунд
есть такие показатели, на которые сегодня тоже можно ориентироваться.
50:29
50 минут 29 секунд
Например, у нормали перед неё ты как бы не понимаешь, вроде как бы он на границе, но в то же время ты там,
50:34
50 минут 34 секунды
например, видишь, что у него есть немножечко избыточный вес, что у него,
50:38
50 минут 38 секунд
допустим, у родителей какая-то какие-то ранние сердечно-сосудистые заболевания,
50:42
50 минут 42 секунды
то есть ты как бы хочешь рассчитать его риск или там он просит это сделать.
50:46
50 минут 46 секунд
Здесь такой показатель, как липопротеин амалая, да, вот внизу он написан липопротеин в скобочках амалая, он так и называется. Он сдаётся вообще один раз в
50:54
50 минут 54 секунды
жизни. То есть это даже не нужно сдавать каждый год, но после сорока, как правило, каждый человек должен знать вот этот уровень либо протеина амало.
51:03
51 минута 3 секунды
Значит, э в чём его информативность? Да,
51:07
51 минута 7 секунд
он указывает, во-первых, на семейную или наследственную гиперхолестеринемию. Он указывает на высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. То есть вот такое это в дополнение. Так вот, на,
51:18
51 минута 18 секунд
конечно, рутины это вы не будете определять, но есть ситуации, когда это делать нужно. Аполипопротеин А и аполипопротеин В - это тоже две такие
51:26
51 минута 26 секунд
фракции, которые можно оценить и тоже получить достаточно много информации.
51:31
51 минута 31 секунда
АПАБ - это атерогенная фракция, плохой холестерин, атероген апа. А это антиатерогенная частица. и их
51:40
51 минута 40 секунд
соотношение аполипопротеина В к аполипопротеину А, оно может указывать и является даже более точным мартёром
51:48
51 минута 48 секунд
сердечно-сосудистых заболеваний, чем холестерин липопротеидов низкой плотности. То есть вот это просто тоже имейте в виду, не забывайте. Если мы говорим об оценке функции печени, да,
51:59
51 минута 59 секунд
теперь поговорим об этом, то, конечно же, основное, на что мы будем обращать внимание - это на ферменты печени. Любое поражение приводит к
52:07
52 минуты 7 секунд
разрушению клеток печени и выходу внутриклеточных ферментов печени,
52:12

52 минуты 12 секунд
которые, конечно, попадают в кровь. Если мы говорим АСТ и АЛТ - это как бы основные ферменты, да, безусловно, но помните о том, что АСТ - это та фракция,
52:21
52 минуты 21 секунда
которая может ещё и выделяться при,
52:24
52 минуты 24 секунды
допустим, поражении сердечной мышцы, при поражении просто скелетных мышц,
52:28
52 минуты 28 секунд
например, при полимиазитах. Поэтому есть такой коэффициент деритиса. Он так называется коэффициент деритиса. Это
52:36
52 минуты 36 секунд
соотношение аст КЛТ. И если оно преобладает, да, в большей степени за счёт фракции АСТ, а АТ сниже, ну там ниже как бы этот показатель, значит,
52:46
52 минуты 46 секунд
скорее всего, речь идёт о, а непечёночных заболеваниях, то есть он будет больше одного ит. Если напротив
52:53
52 минуты 53 секунды
идёт, он уменьшен, да, и преобладает фракция Ал, значит, скорее всего речь идёт об истинном заболевании печени.
53:00
53 минуты
Такой коэффициент деритиса.
53:03
53 минуты 3 секунды
Гаммаглутамилтранспектиптидаза очень характерна для алкогольного гепатита. У алкоголиков очень часто повышены именно ГГТ вот этот печёночный фермент, но также при повреждении печени тоже.
53:14
53 минуты 14 секунд
щелочная фосфотаза, не забывайте, она может наблюдаться и при холестазе, но и при заболеваниях костей. Вот это тоже
53:23
53 минуты 23 секунды
может быть. И в том числе при остеопорозе именно повышаться а щелочная фосфотаза, белирубин, да, обязательно на
53:31
53 минуты 31 секунда
него смотреть, то есть повышение разных фракций. То есть белирубин обычно создаётся общий, прямой и непрямой, да?
53:37
53 минуты 37 секунд
Ну, любое повышение белерубина в любом случае укажет нам, да, на поражение печени, либо это может быть поражение
53:43
53 минуты 43 секунды
желчного пузыря. Тогда здесь надо как бы смотреть именно фракции. Повышение именно прямого белерубина - это, как правило, холестаз, а напротив, непрямого
53:52
53 минуты 52 секунды
белерубина и очень часто бывает игимолис и синдром жельбера, в том числе. А что касается функции почек, обязательно смотреть на такие показатели, как креатинин, мочевина, мочевая кислота.
54:03
54 минуты 3 секунды
Вот эти три показателя. креатинин он почему мы как бы на них обращение внимания эти три показателя выводятся почками креатинин - это то вещество
54:12
54 минуты 12 секунд
которое образуется в мышечной ткани поэтому, да, мы понимаем, что у мужчин исходной этот уровень будет чуть выше,
54:17
54 минуты 17 секунд
чем у женщин. А, но, естественно, если мы видим его повышение, значит, мы говорим о том, что здесь явно идёт проблема с почками, там острая почная хроническая, гломеролонефрит,
54:28
54 минуты 28 секунд
пилонефрит, то есть какое-то инфекционное заболевание на ищите.
54:32
54 минуты 32 секунды
Значит, проблема, скорее всего, в этом тоже есть. Мочевина. Мочевина - тот побочный продукт, который образуется в процессе распада белков. И вы понимаете,

54:40
54 минуты 40 секунд
да, что это обязательно в организме постоянно происходит катаболизм белков.
54:45
54 минуты 45 секунд
И поэтому причин она опять же выводится почками. И если мы видим повышение уровня мочевины, значит, опять же ищите
54:52
54 минуты 52 секунды
проблему с почками. Но это может быть и связано с обструкцией мочеводящих путей,
54:58
54 минуты 58 секунд
с сахарным диабетом, а приём кортикостероидов. Очень часто на этом фоне тоже может повышаться мочевина,
55:05
55 минут 5 секунд
потому что мы говорим, это про продукт распада белков, поэтому аналические стероиды, а это тоже может быть наблюдаться, может наблюдаться при этом.
55:15
55 минут 15 секунд
мочевая кислота. Да, мы знаем, что мочевая кислота, и мы как бы у нас сразу такая ассоциация с подагрой, потому что
55:23
55 минут 23 секунды
действительно вот такой постоянно повышенный уровень мочевой кислоты или гиперрикемии приводит к тому, что она начинает откладываться в сеновиальной жидкости, да, в виде таких кристалликов,
55:33
55 минут 33 секунды
приводя к воспалению суставов и возникает подаро. Да, но есть ещё и бессимптомная гиперрикемия, а она
55:40
55 минут 40 секунд
напрямую сегодня доказана связана именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
55:46
55 минут 46 секунд
Основные причины повышения мочевой кислоты - это в том числе и, а, конечно же, и почечная недостаточность, это может быть и сердечная недостаточность,
55:55
55 минут 55 секунд
нарушение функции щитовидной железы на фоне гипотиреоза и гипопаратиреоза, гиперлипидами. ожирение очень часто сопровождается гиперрукемия.
56:07
56 минут 7 секунд
И ещё такой показатель для оценки функции почек - это скорость клубочковой фильтрации. Мы раньше тоже её рассчитывали вручную, но сейчас, если вы
56:15
56 минут 15 секунд
обратите внимание, это тоже дают как бы этот показатель, он является таким ранним признаком начинающейся хронической почной недостаточности, но в
56:23
56 минут 23 секунды
то же время она может уже снижаться там на фоне гипертонии, на фоне сахарного диабета, при сердечной недостаточности.
56:29
56 минут 29 секунд
Вот это вот скорость клубочковой фильтрации. Теперь скажу несколько слов по гормонам щитовидной железы, потому что говорить о лабораторной диагностике как бы не коснуться, ну, скажем так,
56:40
56 минут 40 секунд
нашей королевы метаболизма, щитовидной железы, да, будет неправильно. Но это действительно удивительный орган, потому что те гормоны, которые она выделяет,
56:49
56 минут 49 секунд
они участвуют практически во всех обменных процессах. Они контролируют обмен веществ, энергии, процессы роста,
56:56
56 минут 56 секунд
деления клеток, созревания тканей и органов. Соответственно, если их недостаточно, то есть имеет место гипофункция щитовидной железы, то,
57:06
57 минут 6 секунд
естественно, обменные процессы замедляются, и организму хронически не хватает энергии. Вот вам симптомы
57:14

57 минут 14 секунд
гипотиреоза. Это и слабость, и сонливость, и набор веса, вечно такая зяпкость, холодные руки, снижение гемоглобина, эритроцитов, выпадение
57:23
57 минут 23 секунды
волос, такое замедление всех умственных процессов, бродикардии, склонность к запорам. Это характерные мексидема, да,
57:30
57 минут 30 секунд
или гипотиреоз. Если, напротив, это тириотоксикоз, если гормонов много, то
57:36
57 минут 36 секунд
все процессы, да, ускоряется основной обмен, ускоряются все обменные процессы.
57:42
57 минут 42 секунды
Это и тревога, это и бессонница, это постоянная тахикардия, вот такая вот дрожь постоянно такая влажная кожа. Это
57:50
57 минут 50 секунд
может быть нарушение, могут быть нарушения ритма, потери веса, напротив,
57:54
57 минут 54 секунды
да, если здесь при наоборот гипофункции набор веса, то при гиперфункции напротив, а потеря веса.
58:02
58 минут 2 секунды
Это как бы тоже основные значения, да,
58:05
58 минут 5 секунд
на что обращать внимание, да, вот Т3 и Т4 - это как раз те гормоны щитовидной железы, которые она вырабатывает.
58:12
58 минут 12 секунд
и ТТГ это значит все выработка гормонов щитовидной железы, она идёт под воздействием гипоталамуса и гипофиза,
58:20
58 минут 20 секунд
да, который, то есть центральное регулирование выработки гормонов щитовидной железы. Соответственно, если мы наблюдаем причины снижения, да, какие
58:28
58 минут 28 секунд
могут быть причины снижения, это состояние гипотиреоза, дефицит йода,
58:32
58 минут 32 секунды
потому что йод - это необходимый микроэлемент, который идёт для синтеза гормонов щитовидной жизни. Учитывая, что мы как бы эндемический очаг по а
58:41
58 минут 41 секунда
йододефициту, то, конечно же, здесь мы тоже говорим о том, что на фоне дефицита йода, отравления, да, или болезни самих
58:51
58 минут 51 секунда
клеток щитовидной железы, тот же аутоиммунный тиреидит, а может ещё и также снижаться синтез синтез гормонов щитовидной железы, а, ну и снижение,
59:00
59 минут
конечно же, выработки териотробного гормона. Всё работает как бы также у них по механизму обратной связи. Если мы
59:08
59 минут 8 секунд
говорим по о причинах повышения, то есть гипертиреоза, повышение синтеза гормонажи - это в первую очередь токсический зоб, да, это тоже такое
59:16
59 минут 16 секунд
воспалительное заболевание, токсический зоб, опухоли, это та же аденома, да,
59:20
59 минут 20 секунд
щитовидной железы, то есть с гормональной активностью, конечно же,
59:23
59 минут 23 секунды
тоже опухоли гипофиза, послеродовая дисфункция, приём некоторых лекарственных веществ. На что проверять,
59:30
59 минут 30 секунд

да, основное, что мы берём - это гормоны щитовидной железы тироксин и три йодтиронин. обязательно синтез йода, поэтому, ой,
59:38
59 минут 38 секунд
нужен йод для синтеза этих гормонов.
59:40
59 минут 40 секунд
Естественно, на фоне его снижения будет наблюдаться, снижение выработки. А что достаточно, если мы подозреваем гипотиоз? Достаточно взять даже только
59:49
59 минут 49 секунд
свободный Т4 и ТТГ. Всё. Ну, ТТГ обязательно, дабы как бы проконтролировать вот этот вот центральный механизм выработки этих
59:57
59 минут 57 секунд
гормонов. Т4 и ТТГ достаточно для диагностики гипотиреоза, потому что Т3 он как бы в три-четыре раза активнее,
1:00:06
1 час 6 секунд
чем Т4, поэтому его концентрация в 10, а то и в 20 раз ниже. Если речт о гипертиреозе, вы подозреваете, то тогда
1:00:13
1 час 13 секунд
лучше сдать и Т3, и Т4. Вот поэтому на это тоже обращайте внимание. Что касается микроэлементов, я обещала сказать, что в первую очередь это,
1:00:22
1 час 22 секунды
конечно же, калий натрий хлор, то, что мы в первую очередь будем рекомендовать,
1:00:27
1 час 27 секунд
как правило. Но если же как бы, да, я специально привела сюда ещё такие,
1:00:31
1 час 31 секунда
наверное, самые основные, на которые тоже, а, сегодня можно взять это совершенно спокойный анализ. Ну, магний в первую очередь, да, это нормализация
1:00:39
1 час 39 секунд
функционер системы, это и спазмолитическое сосудорасширяющее свойство. Ну, можете проверить, если уж подозреваете такой дефицит магния.
1:00:48
1 час 48 секунд
Марганиц - это в первую очередь белковый и фосфорный обмен, да, тоже, но также он ещё и участвует в синтезе витаминов группы Б, да, и некоторых гормонов.
1:00:58
1 час 58 секунд
Селен тоже такой уникальный микроэлемент, потому что он ещё и отделяет йод и участвует таким образом,
1:01:04
1 час 1 минута 4 секунды
да, в синтезе гормонов щитовидной железы. И ещё он, а, является таким,
1:01:10
1 час 1 минута 10 секунд
скажем так, элементом антиоксидантной защиты. он входит в некоторые ферменты,
1:01:16
1 час 1 минута 16 секунд
которые являются компонентами антиоксидантной защиты. Вот в том числе предохраняет витамин Е от разрушения. А витамин Е, да, - это тот же самый такой
1:01:25
1 час 1 минута 25 секунд
активный компонент антиоксидантной защиты. Цинк. Цинк в первую очередь это и а иммунная система, да, нормальное
1:01:33
1 час 1 минута 33 секунды
функционирование иммунной системы и нервной системы, зрительной,
1:01:36
1 час 1 минута 36 секунд
репродуктивной. Ну редко бывает такое, что мы наблюдаем прямо такой уж дефицит цинка. Это правда бывает редко, но тем не менее такое
1:01:45
1 час 1 минута 45 секунд

критическое его снижение, ну действительно может привести к такой задержке роста, к иммунодефицитом, к к экземе, а тоже может приводить. Что
1:01:54
1 час 1 минута 54 секунды
касается анализа крови на витамина, это тоже очень часто спрашивают. Сразу скажу, вы должны запомнить, что если это
1:02:02
1 час 2 минуты 2 секунды
здоровые лица, там люди, городские жители, да, как и на с нормальным полноценным питанием, а витаминоза у них
1:02:10
1 час 2 минуты 10 секунд
не бывает, то есть может не быть, если это как бы взрослые, не беременные люди,
1:02:15
1 час 2 минуты 15 секунд
которые питаются полноценно и разнообразно, никакие витаминные добавки им не нужны, если только это не
1:02:23
1 час 2 минуты 23 секунды
определённые группы, если это вот именно люди с неполноценным питанием. Это вегетарианство, это, а, допустим, там
1:02:31
1 час 2 минуты 31 секунда
действительно какое-то соблюдение постов, там очень строго. Это люди с синдромом малябсорпции, когда мы точно знаем, особенно да, у пожилых пациентов,
1:02:40
1 час 2 минуты 40 секунд
когда все эти неспецифический язвенный калит или интерит, да, вот это тоже тогда мы действительно можем заподозрить
1:02:47
1 час 2 минуты 47 секунд
дефицит жизненно важных витаминов, если это люди, да, с определёнными симптомами, там опять же даже хроническая усталость, нехватка энергии,
1:02:55
1 час 2 минуты 55 секунд
сухость кожи, выпадение волос, ну, в том числе можно посмотреть и это. А заболевания такие, как рахит или
1:03:03
1 час 3 минуты 3 секунды
гиперпаратиреоз, которые действительно могут стать причинами гиповитами гиповитаминозов. Аутоиммунные заболевания, да, можно для людей с нарушением обмена веществ, с ожирением,
1:03:14
1 час 3 минуты 14 секунд
да, те, кто просто хочет проверку, там сделать проверку своего витаминного статуса или контроль за лечением для людей, которые употребляют поливитаминные комплексы. Но в целом,
1:03:24
1 час 3 минуты 24 секунды
среди всего этого комплекса анализов на витамины, я выбираю и в первую очередь витамин D, который я считаю, что можно использовать в том числе и в чекапах.
1:03:34
1 час 3 минуты 34 секунды
Это действительно очень важный витамин,
1:03:36
1 час 3 минуты 36 секунд
который регулирует процессы обмена кальция и фосфора. От него зависит минерализация костей. Но и это не всё.
1:03:43
1 час 3 минуты 43 секунды
Да, он поддерживает и врождённый,
1:03:45
1 час 3 минуты 45 секунд
приобретённый иммунитет, тонус скелетной мускулатуры, обеспечивает нормальное функционирование нервной сердечно-сосудистой системы, обладает
1:03:54
1 час 3 минуты 54 секунды
онкопротективным действием, участвует в регуляции углеводного и жирового метаболизма, даже положительно влияет на женскую и мужскую фертильность. То есть
1:04:03
1 час 4 минуты 3 секунды
это обязательная, скажем так, составляющая,
1:04:06
1 час 4 минуты 6 секунд
да, любого чекапа в профилактике возраст зависимых заболеваний. Да, витамин D из всех витаминов я выделяющи считаю, что на него нужно обращать внимание в первую

1:04:15
1 час 4 минуты 15 секунд
очередь среди прочих аа обязательно смотреть, это норма или это недостаточность или это выраженный дефицит. Дальше идёт подбор дозы в
1:04:23
1 час 4 минуты 23 секунды
зависимости от тех показателей, да, это вообще не сложно. Там, если нужно будет,
1:04:28
1 час 4 минуты 28 секунд
я вам пришлю всякие таблицы, когда ты смотришь как бы на пересечение, какой у него а сейчас уровень, какой он должен быть. на пересечении ты выходишь на ту
1:04:37
1 час 4 минуты 37 секунд
дозировку витамин D, которую ты обязательно должен дать, потому что, да,
1:04:41
1 час 4 минуты 41 секунда
если мы имеем дело с дефицитом витамина D, то, конечно же, начинает компенсироваться уровень кальция
1:04:48
1 час 4 минуты 48 секунд
повышаться, да, за счёт того, что начинается его начинается выработка, гиперфункция паращитовидных желёз,
1:04:55
1 час 4 минуты 55 секунд
начинает вымываться кальций из костей,
1:04:58
1 час 4 минуты 58 секунд
что приводит, естественно, к остеомоляции, к остеопорозу, к рахиту у детей. Поэтому плюс - это и аутоиммунные
1:05:05
1 час 5 минут 5 секунд
заболевания, это некоторые виды онкологических заболеваний,
1:05:09
1 час 5 минут 9 секунд
колларектальный рак, в том числе гипертония, заболевания сердца, множественный склероз, сахарный диабет.
1:05:15
1 час 5 минут 15 секунд
Поэтому обязательно на этот показатель обращайте внимание. Ну и риск развития дефицита витамина D особенно высок. Это
1:05:22
1 час 5 минут 22 секунды
у людей с нарушениями всасывания. И вот те люди, да, пожилые люди, лица, а жители, вернее, северных широт, кто как бы не дополучает солнечного света, да,
1:05:32
1 час 5 минут 32 секунды
под воздействием которых синтезируется витамин D, тоже в целях профилактики можно рекомендовать препараты,
1:05:38
1 час 5 минут 38 секунд
содержащие витамин D, потому что те симптомы, да, те же боли в костях слабости, отсутствие энергии, чрезмерное
1:05:45
1 час 5 минут 45 секунд
потоотделение, всё время тоже такая вот влажная кожа и потливость повышенная,
1:05:50
1 час 5 минут 50 секунд
замедленный рост у детей, очень высокий риск перелома, частый распира раторной инфекции на фоне низкой иммунной защиты,
1:05:58
1 час 5 минут 58 секунд
депрессивные состояния, ну, волосы,
1:06:00
1 час 6 минут
ногти, ухудшение заживлений ран и развитие хронических заболеваний, о которых мы с вами уже говорили, также возможна манифестация их на фоне именно
1:06:10
1 час 6 минут 10 секунд
дефицита витамина D. Что касается теперь общего анализа мочи, сразу два слова скажу. По сдаче анализа, по правилам
1:06:17
1 час 6 минут 17 секунд
сдачи, да, анализа в крови обязательно это делать на тощах. Даже кто-то скажет: "Ну, общее-то зачем на тощах?" Ну,
1:06:23

1 час 6 минут 23 секунды
биохимия понятны, как минимум двенадцатичасовой интервал голодания. А зачем общий? Да, да, тоже на тощак.
1:06:31
1 час 6 минут 31 секунда
Потому что именно при, вернее, приём пищи может приводить к увеличению лейкоцитов. Это может быть несколько ложнозавышенный результат. Поэтому и тот, и другой анализы сдаются на тощак.
1:06:42
1 час 6 минут 42 секунды
Тоже касается и гормонов щитовидной железы. Это нужно делать по, ну,
1:06:47
1 час 6 минут 47 секунд
максимально избегая стрессов, не волноваться, всё это сдавать. Что касается мочи, да, мы говорим о том, что обязательно обращать внимание на цвет,
1:06:56
1 час 6 минут 56 секунд
потому что всегда красный цвет, цвет мясных помоев означает какую-то примесь крови, да, это может быть и нефролитиаст, тот идут камни, да, это
1:07:05
1 час 7 минут 5 секунд
может быть гломерулонефрит или обострение хронического, а гломерулнефрит или острый, да, или хронический. То есть обязательно на это
1:07:13
1 час 7 минут 13 секунд
обращать внимание. цвет пива зеленовато бурый, значит, явно идёт какая-то желтуха, да, вот за счёт вот этого белирубина и уробелиногена, который
1:07:21
1 час 7 минут 21 секунда
окрашивают мочу. Прозрачность, любое помутнение - это инфекция. То есть тоже смотрите внимательно. Удельный вес
1:07:29
1 час 7 минут 29 секунд
обязательно это сколько соли, да, там растворено, да, опять же, если это обезбоживание, усиленное пото отделение может быть повышаться, может повышаться
1:07:36
1 час 7 минут 36 секунд
отдельный вес. Реакция паш очень часто указывает на, ну, она должна быть в норме, и любые её изменения указывают там на возможности образования уратных
1:07:44
1 час 7 минут 44 секунды
или акслатных или фосфатных камней. В норме белка в моче быть не должно,
1:07:50
1 час 7 минут 50 секунд
глюкозы тоже. Если, естественно, там начинают появляться глюкоза, то это, в первую очередь может быть и диабет, это может быть и панкреатит, там минингит,
1:07:58
1 час 7 минут 58 секунд
энцефалиты,
1:07:59
1 час 7 минут 59 секунд
тиреотоксикоз. Тоже может приводить к появлению глюкозы в моче. Кеновые тела,
1:08:05
1 час 8 минут 5 секунд
да, тоже не должны быть, но если их описывают, то это может быть и диабет, это может быть и хронический алкоголизм,
1:08:13
1 час 8 минут 13 секунд
острые инфекции, обширные травмы мышц. И теперь нитриты, как бы нитритов тоже нет, но если это они появляются, это указывает на воспалительные заболевания.
1:08:24
1 час 8 минут 24 секунды
Эритроциты, появление осадка, да,
1:08:26
1 час 8 минут 26 секунд
смотрим осадок. Эритроциты, это в первую очередь, скорее всего, будет гломеролонефрит, но могут быть и камни,
1:08:33
1 час 8 минут 33 секунды
да, идут камни, они царапают всё, и появляются эритроциты. Но аденомопростаты тоже может быть рак почек, мочевого пузыря. Рак почки вообще
1:08:41

1 час 8 минут 41 секунда
очень коварная такая, а, ситуация, когда долго о себе вообще может не заявлять и бывает случайной находкой. Лейкоциты в
1:08:50
1 час 8 минут 50 секунд
первую очередь, конечно же, указание на воспалительный процесс. Эпителий.
1:08:55
1 час 8 минут 55 секунд
Эпителий случается тогда, когда в первую очередь идёт инфекция, значит, появление эпители. И смотря какой он, да, может
1:09:03
1 час 9 минут 3 секунды
быть плоский, переходный или почечный, в зависимости от локализации, может указывать нам на инфекцию там мочполовой системы или выше, там это цистит,
1:09:11
1 час 9 минут 11 секунд
пионефрит и почны, эпителий - это гларолонефрит или пилнефрит. Цилиндры то же самое, да, скоплениеле молекул белка,
1:09:20
1 час 9 минут 20 секунд
эпителия, то есть идёт слущни, они скручиваются с молекулами. Ясно, что речь идёт, скорее всего, о воспалительных заболеваниях. Бактерии
1:09:28
1 час 9 минут 28 секунд
сами за себя говорят. Их быть, конечно же, не должно. Кристаллы - это осадки из солей, которые тоже содержатся в моче и
1:09:36
1 час 9 минут 36 секунд
а могут косвенно свидетельствовать о мочеками, склонности к мочекаменной болезни. Слизь большое количество - это тоже признак воспаления. Что касается копрограммы,
1:09:47
1 час 9 минут 47 секунд
да, то тут мы тоже обязательно обращаем внимание на цвет, то есть ахаличный или обесцвеченный кал. Это признак отсутствия стеркабелина, то есть не попадает желчь. Почему она не поступает?
1:09:58
1 час 9 минут 58 секунд
Значит, имеется какая-то блокада желчеводящих путей. Напротив, оче очень тёмный кал или это, скорее всего, идёт
1:10:07
1 час 10 минут 7 секунд
какое-то кровотечение из верхних отделов кишечника. Там красный цвет, чёрный цвет, да, тоже признак кровотечения,
1:10:13
1 час 10 минут 13 секунд
красный цвет из нижних отделов. Слизь -
1:10:16
1 час 10 минут 16 секунд
признак воспалительных процессов. Детрит - это как бы частички непереваренной пищи. Лейкоциты, признаки воспаления.
1:10:23
1 час 10 минут 23 секунды
жир, жирные кислоты, мыло, признаки недостаточности поджелудочной железы. Ну и эритроциты, понятно, что это, скорее всего, результат кровотечения, бактерии,
1:10:32
1 час 10 минут 32 секунды
грибы, инфекция. Ну и эпителий как признак воспалительного процесса. Ну,
1:10:36
1 час 10 минут 36 секунд
немножечко покажу, да, вот такие, как вы можете, например, встретиться, да, вот тоже просто мы это тоже всё с вами обговорили. Вы видите ещё вроде, да,
1:10:44
1 час 10 минут 44 секунды
гемоглобин вообще, ну, так чуть ближе к нижней границе, но ещё не сниже.
1:10:48
1 час 10 минут 48 секунд
Эритроциты вроде как даже выше нормы, но при этом они, а, они все как бы цветовые показатели их снижены, и нам пишут
1:10:57
1 час 10 минут 57 секунд
микроцитоз и гипохромия. То есть нам уже как бы есть такой некий намёк на то,
1:11:02
1 час 11 минут 2 секунды
чтобы тут надо, что тут нужно искать какой-то скрытый латентный железодефицит. Вот такие показатели,
1:11:09
1 час 11 минут 9 секунд

как, например, в процентах 0,7 вообще можно либо вы их пересчитываете на в абсолютные, либо это вообще, скорее
1:11:16
1 час 11 минут 16 секунд
всего, гемодинамически незначимый показатель. Ну, нейтрофилы здесь вот показаны в виде а повышения в абсолютном
1:11:25
1 час 11 минут 25 секунд
количестве. Ну, может быть, здесь и лейкоцеты чуть ближе к верхней границе.
1:11:29
1 час 11 минут 29 секунд
Может быть, тоже ещё на фоне какой-то какого-то инфекционного процесса. Здесь тоже а здесь уже явные снижены гематокрит и гемоглобин. вы видите, ну,
1:11:38
1 час 11 минут 38 секунд
эритроцита ещё как бы нет, но здесь явны и все показатели. Вы видите здесь опять же и микроцитоз, и гипохроми, но и здесь
1:11:47
1 час 11 минут 47 секунд
оче здесь и а тромбоцитоз, который может быть в том числе и реакцией на воспалительный процесс. И, конечно же,
1:11:55
1 час 11 минут 55 секунд
повышенное количество лейкоцитов, что может указывать на инфекционный процесс.
1:11:59
1 час 11 минут 59 секунд
Инфекционный процесс, воспалительный процесс, это очень часто лейкоцитоз, это анемия и повышенная соя. Вот такие вот
1:12:07
1 час 12 минут 7 секунд
такая триада инфекционного процесса. А что касается и здесь, да, это биохимический процесс, да, кстати, вот мы говорили уже, да, об
1:12:16
1 час 12 минут 16 секунд
инсулинорезистентности. Я не сказала вам, как можно рассчитать инсулинорезистентность. Если вам это будет интересно, я вам потом всё это пришлю обязательно. У меня это всё есть.
1:12:25
1 час 12 минут 25 секунд
Как рассчитывать индексы инсулинорезистен. То есть есть такое лабораторное исследование, как непосредственно определение
1:12:33
1 час 12 минут 33 секунды
инсулинорезистентности. Это лабораторная методика. Но есть ещё и косвенные показатели, с помощью которых вы можете сами рассчитать у ваших клиентов и
1:12:42
1 час 12 минут 42 секунды
говорить о наличии у них инсулинорезистентности. Я вам пришлю. Здесь явная есть инсулинорезистентность, рассчитанная по
1:12:50
1 час 12 минут 50 секунд
критериям высокий инсулин, да, с чего он будет? Значит, к нему есть резистентность, высокий холестерин. А,
1:12:57
1 час 12 минут 57 секунд
ну здесь, видимо, немножечко они показывают, что он, а, должен быть как бы у них отного ид, хотя вот 1,19 тоже
1:13:05
1 час 13 минут 5 секунд
неплохо, но холестерин липопротеида низкой плотности 3,46, это всё-таки высокий, мы говорим даже для низкой, а,
1:13:14
1 час 13 минут 14 секунд
низкого риска он должен быть меньше трёх, а тут уже есть инсулинорезистентность, значит, он должен быть ещё ниже. Ну или здесь вот,
1:13:22
1 час 13 минут 22 секунды
пожалуйста, анализ мочи. Здесь и белок, здесь и кетоновые тела.
1:13:26
1 час 13 минут 26 секунд
Эритроциты явная а речь идёт о каком-то воспалительном процессе в почках.
1:13:32
1 час 13 минут 32 секунды
Обязательно на это обращайте внимание. И буквально несколько слов, потому что рассматривать как бы инструментальные методы там в отрыве от лабораторных или наоборот, это не совсем правильно.
1:13:43

1 час 13 минут 43 секунды
Поэтому мы говорим как бы в купе о лабораторно инструментальном обследовании профилактике возраст зависимых заболеваний. Вот они наши
1:13:51
1 час 13 минут 51 секунда
основные возрастзависимые заболевания. И вы видите, а я не буду повторяться,
1:13:56
1 час 13 минут 56 секунд
наверняка вам на каждой лекции об этом говорят, и вы видите, что в структуре опять же на первом месте сердечно-сосудистые заболевания.
1:14:05
1 час 14 минут 5 секунд
Поэтому, конечно же, наша с вами задача - это профилактировать именно эти заболевания. Конечно же, мы уже говорили с вами о том, что вот это диабесити, да,
1:14:15
1 час 14 минут 15 секунд
это сочетание диабета и оживения, очень частое сосуществование, которое приводит к колоссальному увеличению риска.
1:14:23
1 час 14 минут 23 секунды
мультифокального атеростероза. Я уже не говорю про ишемическую болезнь, про инфаркт, про гипертонию, про инсульты,
1:14:30
1 час 14 минут 30 секунд
про тромбозы, про падагру и так далее. И поэтому, а, в первую очередь речь идёт именно о ожирении по типу яблока, да? То
1:14:38
1 час 14 минут 38 секунд
есть обязательно оценивайте статус пациента с точки зрения клинического,
1:14:42
1 час 14 минут 42 секунды
да? То есть это индекс массы тела, это отношение объёма талии к объёму бёдер,
1:14:46
1 час 14 минут 46 секунд
то есть выявление вот этого ожирения абдоминального, висцерального,
1:14:51
1 час 14 минут 51 секунда
центрального, по типу яблока, как хотите его назовите. Но оно самое неблагоприятное, а, в плане развития
1:14:58
1 час 14 минут 58 секунд
сахарного диабета второго типа и б - это мультифокальный атеросклероз. Поэтому ваша задача чётко выявлять те
1:15:07
1 час 15 минут 7 секунд
индивидуальные факторы риска. Пол, как ни странно, да, мужской пол это является, а, таким своеобразным фактором
1:15:14
1 час 15 минут 14 секунд
риска, да, для сердечно-сосудистых заболеваний, потому что мужчины сегодня это даже помолодел, уже старше сорока,
1:15:21
1 час 15 минут 21 секунда
мы уже начинаем как бы тут более прицельно их обследовать. Женщины до поры до времени, пока у них не наступил
1:15:29
1 час 15 минут 29 секунд
период менопаузы, они находятся под некой такой кардиопротективным действием женских половых гормонов, но с угасанием и с
1:15:37
1 час 15 минут 37 секунд
наступлением менопаузы. Они приравниваются по своим рискам с мужчиной. Возраст, опять же повторюсь,
1:15:44
1 час 15 минут 44 секунды
для мужчин уже там после птидесяти мы уже тоже начинаем волноваться.
1:15:48
1 час 15 минут 48 секунд
Наследственности, особенно в молодом возрасте ранние, да, такие события сердечно сосусо у родственников первой линии, но это тоже нас очень должно
1:15:56
1 час 15 минут 56 секунд
напрягать. Физическая активность, факт курения, употребления алкоголя, масса тела, индекс массы тела. То есть вот то,
1:16:03
1 час 16 минут 3 секунды
что я вам говорила на это обращайте внимание. Липидограма, обязательно глюкоза крови и, конечно же, давление.

1:16:09
1 час 16 минут 9 секунд
То есть вы должны не пропускать там на приёмели, либо он вам жалуется какой-то даёт вам дневничок давления. Не пропускайте, потому что на это тоже
1:16:18
1 час 16 минут 18 секунд
нужно обращать внимание. и в ваших же за в ваших же силах, да, рассчитать вот тот у них абсолютный риск смерти, который
1:16:26
1 час 16 минут 26 секунд
можно проводить наглядно по шкалом скорд, где учитывается факт курения, цифры артериального давления, пол,
1:16:34
1 час 16 минут 34 секунды
возраст и цифры холестерина. Это скор. А есть ещё скор два - это вторая самая как бы новая такая таблица. Там учитывается
1:16:41
1 час 16 минут 41 секунда
не просто общий холестерин, а холестерин не липопротеидов высокой плотности.
1:16:46
1 час 16 минут 46 секунд
Поэтому на это обращайте обязательно внимание. И вот тут вам очень наглядно,
1:16:51
1 час 16 минут 51 секунда
не только для вас, да, но и для ваших клиентов. А вот если вы будете продолжать курить, там, пить, не соблюдать, не контролировать артериальное давление, то посмотрите,
1:17:00
1 час 17 минут
какой риск сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается функциональной диагностики, да, то рутинное, что мы можем предложить, это, конечно же, и
1:17:09
1 час 17 минут 9 секунд
рекомендовать, да, ЭКГ - это эхокардиографии, УЗИ или УЗДГ, да, дуплексное сканирование, как мы говорим,
1:17:16
1 час 17 минут 16 секунд
сосудов шей, да, то есть это экстракорниального отдела брахиоцефальных сосудов. Почему я всегда считаю, что это вот как бы вот эти три -
1:17:24
1 час 17 минут 24 секунды
это как бы самый минимум, который мы должны проводить в чекапах, потому что вот то состояние брахиоцефальных артерий, вот их экстракрониального
1:17:32
1 час 17 минут 32 секунды
отдела, оно, как правило, отражает мультифокальное такое вот как бы общее отражение о о сосудах. То есть, если я здесь явно вижу бляшки, то значит
1:17:41
1 час 17 минут 41 секунда
наверняка они будут и в коронарных артериях, и в сосудах нижних конечностей. Поэтому это очень показательный для нас такой вот
1:17:48
1 час 17 минут 48 секунд
результат. узи почек, почечных артерий обязательно в плане особенной гипертонии. Ну и потом, да, при для того, чтобы проверить функцию почек, в
1:17:56
1 час 17 минут 56 секунд
том числе исключить вторичный аа вторичный характер гипертонии, который может быть на фоне почных заболеваний,
1:18:03
1 час 18 минут 3 секунды
нагрузочные тесты в случае каких-либо болей в сердце. Обязательно исключать ишемическую болезнь с помощью вот этих
1:18:11
1 час 18 минут 11 секунд
вот нагрузочных тестов. Ну и более углублённые, там суточное мониторирование и давление, можно ЭКГ сделать, можно порекомендовать коронар,
1:18:20
1 час 18 минут 20 секунд
если действительно за он вам описывает типичные боли в сердце. Если вы можете там действительно заподозрить ишемическую болезнь сердца, понятно, что
1:18:28
1 час 18 минут 28 секунд
золотой стандарт - это коронараангиография, но проводится она в условиях стационара. Альтернативой этому

1:18:36
1 час 18 минут 36 секунд
служит мультиспиральная компьютерная томография, которая проводится в амбулаторных условиях абсолютно. Но при этом она точно также информативна, то
1:18:43
1 час 18 минут 43 секунды
есть то МСКТ коронарных артерий с контрастированием, когда тоже вводится контраст и точно также виден а видны
1:18:51
1 час 18 минут 51 секунда
стенозы в коронарных артериях. Это можно проводить в амбулаторных условиях при,
1:18:55
1 час 18 минут 55 секунд
естественно, подозрении на ишеническую болезнь. Полисомнографии для диагностики слепопнор. Ну после сердечно-сосудистых
1:19:02
1 час 19 минут 2 секунды
идут онкологические заболевания. Я умышленно ничего не говорила об онкомаркёрах. Почему скажу? Потому что
1:19:10
1 час 19 минут 10 секунд
онкомаркёры рассматривать исключительно как скрининг - это не совсем правильно. То есть это не про это. Онкомаркёры они не про
1:19:19
1 час 19 минут 19 секунд
скрининг. Онкомаркёры в большей степени для всё же подтверждения, да, для дифференциальной диагностики, для оценки
1:19:26
1 час 19 минут 26 секунд
лечения, для возникновения там оценки возникновения, э, повторных заболеваний, да, повторного рецидива, скажем так, да,
1:19:34
1 час 19 минут 34 секунды
рецидива. Поэтому, конечно же, мы диагностику и профилактирование онкозаболеваний начинаем не со скрининга
1:19:42
1 час 19 минут 42 секунды
онкомаркёров, а в первую очередь, да, с таких инструментальных методов диагностики. То есть, если это лёгкий,
1:19:48
1 час 19 минут 48 секунд
это обязательно там и кот или рентген один раз в год, это желудок гастроскопии, там и колмоноскопии. Ну не буду, вы всё видите здесь разные как бы
1:19:56
1 час 19 минут 56 секунд
возрастные интервалы. Кишечник, да. А вот в случае с кишечником помимо колланоскопии после 50 лет это всё же ещё и тест на скрытую кровь. И
1:20:04
1 час 20 минут 4 секунды
обязательно, вот мы говорили о копрограмме, да, и анализ калы на скрытую кровь - это два разных анализа.
1:20:10
1 час 20 минут 10 секунд
Это не одно и то же. Вот это вот анализ кал на скрытую кровь, потому что мы колоректальный рак, к сожалению, очень долго может о себе не заявлять, и мы его
1:20:19
1 час 20 минут 19 секунд
можем пропустить. Кожа там предстательная железа. Но в случае с предстательной железой тот же анализ крови на ПСА, простат специфический антиген, он может быть рекомендован
1:20:27
1 час 20 минут 27 секунд
мужчинам а после 51 раз в год. Это правда. Это вот как раз тот скрининг, но он может бы Почему я про онкомаркёры так
1:20:35
1 час 20 минут 35 секунд
говорю, да? Потому что нет такого онкомаркёра, который бы чётко повышался,
1:20:40
1 час 20 минут 40 секунд
вот строго при этом виде рака. Нет, к сожалению, некоторые виды рака могут вообще о себе не заявлять и быть вообще маркёрнегативными.
1:20:49
1 час 20 минут 49 секунд
другие напротив неонкологические заболевания могут повышать онкомаркёры, и мы уходим совершенно по-другому пути,
1:20:58
1 час 20 минут 58 секунд

там, вызывая ужас у наших клиентов.
1:21:00
1 час 21 минута
Поэтому вот здесь нужно очень-очень тонко, если действительно в купе с с инструментальной диагностикой, там той
1:21:07
1 час 21 минута 7 секунд
же маммографии или УЗИ молочных желёз или осмотр шейки матки, мы действительно что-то заподозрили, вот тогда мы можем
1:21:16
1 час 21 минута 16 секунд
присоединить сюда онкомаркёры. и посмотреть всё же, что здесь возможно подтвердиться, а может быть и нет. То есть и тоже даже если не подтверждается,
1:21:26
1 час 21 минута 26 секунд
то есть один и тот же вид рака может давать повышение одного и того же онкомаркёра, да, точно так же всё это может быть и наоборот. Поэтому здесь
1:21:34
1 час 21 минута 34 секунды
очень-очень всё так тонко. А заболевание опорно-двигательной системы остеопороз вы видите на сегодня это действительно
1:21:43
1 час 21 минута 43 секунды
оченьочень такая распространённая проблема, поэтому мы обязательно должны рекомендовать денситометрию, дабы не
1:21:50
1 час 21 минута 50 секунд
пропускать даже начальные признаки остеопороза. Рентген - это всё же он даст нам меньше информации вот денситометрии, ультразвуковая
1:21:58
1 час 21 минута 58 секунд
денситометри однозначно должна быть рекомендована и проводиться ежегодно. А,
1:22:04
1 час 22 минуты 4 секунды
особенно, да, у женщин старше даже 60 лет уже она должна проводиться ежегодно.
1:22:10
1 час 22 минуты 10 секунд
Что касается печени, диагностики заболевания печени, это обязательно в купе с лабораторной диагностикой. И если мы действительно, мы уже проговорили все
1:22:18
1 час 22 минуты 18 секунд
эти изменения, не буду повторяться, вот тогда мы можем также то и можем делать это и как бы тоже по в рамках чекапа
1:22:27
1 час 22 минуты 27 секунд
тоже УЗИ печени. Начнём с него. Всё остальное - это уже более углублённые изменения при каких-то возможных
1:22:34
1 час 22 минуты 34 секунды
изменениях, которые вывет ультразвук. То же самое и почки. Да, в любом случае мы будем говорить сначала о лабораторной диагностике, а потом присоединим
1:22:43
1 час 22 минуты 43 секунды
ультразвука. В первую очередь будет ультразвук, а потом дальнейшие более углублённые исследования. Центральная нервная система, конечно же, для нас это просто очень важный вопрос, да,
1:22:55
1 час 22 минуты 55 секунд
затормозить вот то прогрессирование когнитивных расстройств,
1:22:58
1 час 22 минуты 58 секунд
профилактировать заболевания центральной нервной системы. Ну а к ним приводят в первую очередь такие заболевания, как атеросклероз, опять же, да, давайте будем профилактировать его. Гипертония,
1:23:09
1 час 23 минуты 9 секунд
неконтролируемое заболевание сердца и такие как в первую очередь мерцательная аритмия, сахарный диабет. Поэтому, конечно же, те когнитивные нарушения,
1:23:18
1 час 23 минуты 18 секунд
которые возникают, я всегда говорю, есть такие тесты, очень мой любимый, а, тест очень лёгкий, называется миниког. Может быть, вы его знаете, его проводить 2
1:23:27
1 час 23 минуты 27 секунд

минуты. То есть вы называете вашему клиенту три абсолютно рандомных слова, он должен их за вами повторить,
1:23:32
1 час 23 минуты 32 секунды
абсолютно не связанных с собой. Он их повторяет. Всё отлично, молодец. Теперь надо нарисовать циферблат. Он рисует циферблат часов. Он должен и укажите на
1:23:41
1 час 23 минуты 41 секунда
нём время там без 104. Он указы должен показать циферблат, расставить все циферки, указать стрелками большую, малу маленькую, всё это показать. И он насто,
1:23:52
1 час 23 минуты 52 секунды
если он нарисовал этот циферблат,
1:23:54
1 час 23 минуты 54 секунды
замечательно. Обычно на этом бывает спотыкается. А если он нарисовал это замечательно, то тут же ты его просишь назвать те три слова, которые были
1:24:03
1 час 24 минуты 3 секунды
сказаны в начале. И вот настолько идёт переключение внимания, что дальше воспроизвести эти три слова. Бывает им очень сложно, они забывают. И это
1:24:11
1 час 24 минуты 11 секунд
указывает на такие ранние когнитивные нарушения. Поэтому, конечно же, на это тоже обращайте внимание. Ну, насколько
1:24:19
1 час 24 минуты 19 секунд
это возможно. Часто спрашивают про болезнь Альцгеймера, как её можно профилактировать, но тут очень сложно сказать. Это действительно одна из самых
1:24:26
1 час 24 минуты 26 секунд
распространённых причин развития деменции у пожилого у лиц пожилого возраста. Да, здесь, конечно же, к сожалению, распространённость
1:24:35
1 час 24 минуты 35 секунд
неукротима, только увеличивается. э смотреть белок, который можно скажем так, увидеть спинномозговой жидкости и
1:24:44
1 час 24 минуты 44 секунды
смотреть его рутину у всех, вы понимаете, это, конечно же, невозможно.
1:24:48
1 час 24 минуты 48 секунд
Поэтому, так сказать, как правило, она уже не столько профилактируется, сколько диагностицируется. По хроническим
1:24:55
1 час 24 минуты 55 секунд
заболеваниям лёгких, да, мы говорим о том, что сегодня практически каждый третий житель планеты страдает от хобол,
1:25:02
1 час 25 минут 2 секунды
хроническо обструктивной болезни лёгких.
1:25:04
1 час 25 минут 4 секунды
Поэтому, а уж особенно, если это курильщики, да, это, конечно же, аа жители крупных городов, это, конечно же,
1:25:12
1 час 25 минут 12 секунд
очень серьёзные осложнения, которые вот именно приводят к хронической обструктивной болезни лёгких. Ну, здесь
1:25:19
1 час 25 минут 19 секунд
рентген, здесь КТ - это каждый год. И при необходимости это может быть и дальнейшие другие исследования. Поэтому тоже обязательно это смотрим для того,
1:25:31
1 час 25 минут 31 секунда
чтобы не пропустить какие-то другие более серьёзные заболевания, заболевание зрительного аппарата, да, вот та пресбиопека, которая как называется
1:25:39
1 час 25 минут 39 секунд
болезнь вытянутых рук, да, когда так вот как бы от длинных рук, вернее, когда ты пытаешься отодвинуть, чтобы лучше увидеть, это в целом-то возрастная
1:25:47
1 час 25 минут 47 секунд

дальнозоркость. Она расценивается как вариант физиологической нормы. Это как бы неизбежно. Но те заболевания, которые тоже связаны с таким, скажем так,
1:25:57
1 час 25 минут 57 секунд
естественным механизмом старения, та же катаракта, которая связана вот с помутнением хрусталика, и это тоже вот такой вот естественный процесс старения.
1:26:07
1 час 26 минут 7 секунд
Глаукома обязательно измеряет внутриглазное давление, потому что может вообще не иметь никаких симптомов. а, ретинопатии, макулодистрофидом,
1:26:15
1 час 26 минут 15 секунд
кровоизлияние в сетчатку, отслойка сетчатки - это тоже достаточно серьёзные заболевания, которые нужно обязательно
1:26:23
1 час 26 минут 23 секунды
выявлять, вовремя выявлять. Для этого нужны вот такие вот, опять же, нужно рекомендовать вот такие вот обследования, в том числе и у
1:26:31
1 час 26 минут 31 секунда
офтальмолога визиты, которые должны быть запланированы, вы видите здесь в определённые возрастные промежутки. Тоже касается и диагностики расстройств слуха. А вся вот эта вот, да,
1:26:43
1 час 26 минут 43 секунды
старческая, а, старческая тугоухость, пресс биоакузия - это тоже как бы такой,
1:26:49
1 час 26 минут 49 секунд
скажем так, элемент старения, да, и тоже это услух так же, как и зрение, подлежит обязательной регулярной проверке.
1:26:57
1 час 26 минут 57 секунд
Поэтому обязательно мы должны это рекомендовать после 60 лет, каждые 2 года. Это если нет проблем. Если проблем есть, то, конечно, это нужно делать и
1:27:06
1 час 27 минут 6 секунд
чаще. Поэтому здесь я как бы вам вывела сюда вот такие вот некие чекапы, да, то,
1:27:11
1 час 27 минут 11 секунд
что мы можем рекомендовать женщинам более молодого возраста, как лабораторная, так и инструментальная диагностика женщинам более старшего
1:27:19
1 час 27 минут 19 секунд
возраста. Да, в принципе, это всё, о чём мы с вами говорили. Я просто внесла, как бы, если вам будет нужно, я прямо в виде вот таких вот табличек вам всё это
1:27:28
1 час 27 минут 28 секунд
разошлю, чтобы вы сейчас не тратили время и так переживаю, что я долго. Но это вот как раз те основные. То есть,
1:27:34
1 час 27 минут 34 секунды
если мы говорим о более старшем возрасте, там ближе к пятидесяти, да,
1:27:38
1 час 27 минут 38 секунд
здесь мы уже присоединяем анализ кала на скрытую кровь, там 45 +. Здесь мы говорим уже о диагностике остеопороза, о
1:27:46
1 час 27 минут 46 секунд
гастрооколоноскопии, да, колоноскопия обязательно там должна быть 50-55, это как бы обязательные
1:27:53
1 час 27 минут 53 секунды
интервалы. Ну а дальше уже смотреть по мере того, что мы обнаружим. Ну и 50 +,
1:27:58
1 час 27 минут 58 секунд
то есть опять же тот же анализ калы на скрытую кровь. Сюда же идёт диагностика и остеопороза, гастроколона, слух и
1:28:06
1 час 28 минут 6 секунд
зрения тоже уже становятся более частыми. Что касается мужчин, да, 25-40 лет, опять же, все анализы, которые мы с вами проговорили, эхэкг брахиоцефальные,
1:28:16
1 час 28 минут 16 секунд
всё тоже оставляем, особенно, я говорю,

1:28:18
1 час 28 минут 18 секунд
сейчас очень помолодели и сердечно-сосудистые заболевания, лучше перестраховаться, сделать тоже и брахиоцифальные артерии, всё это
1:28:25
1 час 28 минут 25 секунд
пересмотреть. мужчины 40-50 лет. Опять же все те же анализы здесь уже можно присоединять ПСА. Обязательно смотреть.
1:28:34
1 час 28 минут 34 секунды
Но повторюсь, не он не не обязательно сразу пугаться, что это должен быть там рак предстательной железы. Нет, при аденомии он тоже может повышаться. И тут
1:28:42
1 час 28 минут 42 секунды
же тоже обязательно уже и УЗИ предстательно железы, консультация уролого, диагностика остеопороза,
1:28:48
1 час 28 минут 48 секунд
гастроскопия, колоноскопия уже в более старшем возрасте начинает быть рекомендованы. 50 пс опять
1:28:55
1 час 28 минут 55 секунд
же добавляем анализ кала на скрытую кровь. Здесь же опять же и ПСА,
1:29:00
1 час 29 минут
гастрокона, зрение и слух. То есть по сути все те же анализы, просто чуть-чуть их уже становится больше и что-то
1:29:08
1 час 29 минут 8 секунд
становится уже чаще. А таким образом, да, всё, я подвожу итог. На сегодня существует
1:29:15
1 час 29 минут 15 секунд
целый ряд методов лабораторной и инструментальной диагностики. Они действительно направлены на выявление возраст зависимых заболеваний. Именно
1:29:24
1 час 29 минут 24 секунды
вот такое тщательное обследование пациента со стороны и лабораторной,
1:29:29
1 час 29 минут 29 секунд
инструментальной, функциональной диагностики позволяет нам выявить вот на ранних стадиях, да, какие-то заболевания, которые помогут определить
1:29:38
1 час 29 минут 38 секунд
там и тактику ведения, и улучшить прогноз и способствовать здоровому долголетию. Поэтому, конечно же, очень важно регулярно проходить рекомендуемые
1:29:47
1 час 29 минут 47 секунд
методы лабораторные, инструментальные диагностики. Это тот ключ, который помогает нам выявлять заболевания на
1:29:53
1 час 29 минут 53 секунды
самых ранних стадиях и попытаться на них повлиять. Как я недавно прочла, мне очень понравилась китайская мудрость.
1:30:00
1 час 30 минут
Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. То есть максимально профилактировать вот те
1:30:08
1 час 30 минут 8 секунд
возрастзависимые заболевания, приводя к здоровому долголетию. Ну, если мы говорим, да, об обычных примерах, у вас
1:30:15
1 час 30 минут 15 секунд
будут это ещё, наверное, тоже и в разных задачах, то мы вот даже, да, на примере вот такого, да, а достаточно частого
1:30:23
1 час 30 минут 23 секунды
случая, который может встречаться 54 года, 174 рост, 112 вес, то есть явно,
1:30:31
1 час 30 минут 31 секунда
да, идёт превышение массы тела, он курит, не контролирует АД, и уже появляется какая-то боль за грудиный.
1:30:38
1 час 30 минут 38 секунд
Для нас это всегда очень важный фактор в плане развития стенокардии, в дальнейшем возможного инфаркта. Дальше отмечает последние полгода прибавку в весе,
1:30:47

1 час 30 минут 47 секунд
отёчность, вялость, сонливость,
1:30:49
1 час 30 минут 49 секунд
признаки, возможно, да, гипотиреоза. А в анализах крови это и высокая глюкоза, и холестерин, и высокие липопротеиды низкой плотности, триглицериды,
1:30:59
1 час 30 минут 59 секунд
невысокое артериальное давление, плюс гиперрикемия, в общем, всё плохо. Какие факторы риска, да, естественно, вот мы уже всё это перечислили. Тут и курение,
1:31:08
1 час 31 минута 8 секунд
тут и, а, избыточная масса тела, тут и высокий уровень глюкозы, то есть нарушение углеводного, нарушение липидного обмена. Явно ещё и проблемы с
1:31:16
1 час 31 минута 16 секунд
почками тоже нужно всё посмотреть. Либо гиперрикемии, вот именно на фоне его ожирения тоже могут быть. Обязательно
1:31:24
1 час 31 минута 24 секунды
всё вот это физикально зафиксировать и рассчитать. Индекс массы тела, талия, бёдра, АД, всё это посмотреть.
1:31:31
1 час 31 минута 31 секунда
Лабораторное дообследование. Помимо того, что нам дано, давайте посмотрим ещё и гликированный гемоглобин.
1:31:37
1 час 31 минута 37 секунд
Рассчитаем индексы инсулинорезистентности, рассчитаем индексы атерогенности. Давайте посмотрим гормоны щитовидной железы, потому что мы вот эти вот не очень хорошие признаки,
1:31:48
1 час 31 минута 48 секунд
да, отёчность, вялость, сонливость тоже.
1:31:50
1 час 31 минута 50 секунд
Если он указывает на бой за грудиный, но ЭКГ эхо и брахиоцефальный, это я даже не обсуждается. КТ органов грудной клетки.
1:32:00
1 час 32 минуты
Да, потому что он курильщик. Суточный монитор АД. Да, потому что у него повышенное давление. Может быть, он так среагировал на визит к вам. Да, может
1:32:08
1 час 32 минуты 8 секунд
быть, это его, а, дома у него оно низкое. Ну, пусть хотя бы дома контролирует тогда сам дневничок давления ведёт. Нагрузочные тесты имеется в виду, дабы проверить функцию,
1:32:19
1 час 32 минуты 19 секунд
работу, да, именно коронарных отелей в плане кровоснабжения сердца. УЗИ предстатетной железы щитовидной, брюшной полости почек. Ему это тоже будет
1:32:28
1 час 32 минуты 28 секунд
рекомендовано. Таким образом, сегодня мы проговорили, да, и лабораторные,
1:32:32
1 час 32 минуты 32 секунды
инструментальные методы обследования. Мы научились, я надеюсь, да, правильно интерпретировать полученные результаты,
1:32:38
1 час 32 минуты 38 секунд
определили алгоритм назначений лабораторных инструментальных методов исследования в различные возрастные интервалы. Ну и разобрали те примеры
1:32:47
1 час 32 минуты 47 секунд
заключений, которые тоже помогут, я очень надеюсь, вам в дальнейшей практике. Спасибо вам большое за внимание. Я очень надеюсь, что я вас не
1:32:56
1 час 32 минуты 56 секунд
сильно утомила, но тема большая, и мне хотелось бы как бы дать вам много, но в то же время как бы отталкиваясь именно
1:33:02
1 час 33 минуты 2 секунды
от тех практических ситуаций, которые вам могут встретиться. И, ну, надеюсь,

1:33:08
1 час 33 минуты 8 секунд
что хоть что-то вам здесь было нужным и поможет в дальнейшем это вам в вашей практической деятельности. Спасибо большое за внимание. Я сейчас посмотрю,
1:33:19
1 час 33 минуты 19 секунд
а, чат. Аа, спасибо большое. Аа, значит, да, индекс Омега. О, да, есть такое.
1:33:26
1 час 33 минуты 26 секунд
Спасибо, что написали. А значит, что можно сказать про индекс Омега? Ну,
1:33:32
1 час 33 минуты 32 секунды
конечно же, я не скажу, что я кому-то его назначаю. Нет, потому что, ну, как правило, мы имеем уже дело с такими взрослыми пациентами с уже с явными признаками атеросклероза. Поэтому,
1:33:43
1 час 33 минуты 43 секунды
конечно же, здесь это, если это молодые пациенты, да, или вот что-то, ну, вот в этом случае можно, так скажем,
1:33:50
1 час 33 минуты 50 секунд
поиграться, поназначать им этот индекс омега-3, но это в большей степени, когда там, ну, нет никаких факторов риска, не повышен общий холестерин. Ну, давайте
1:33:59
1 час 33 минуты 59 секунд
посмотрим индекс омега-3. Всё-таки я больше ориентируюсь на липидограмму, но знаю, да, есть такое исследование, конечно, да, можно, почему нет.
1:34:07
1 час 34 минуты 7 секунд
Особенно, если там, я говорю, достаточно молодой возраст, но возможно какие-то есть факторы, а такие вот отсегчающие там тот же ранний анамнез, там у родите
1:34:15
1 час 34 минуты 15 секунд
наследственный отягочённый наследственный анамс и так далее. А какие исследования могут быть индикаторами биологического возраста?
1:34:24
1 час 34 минуты 24 секунды
Спасибо большое. Да, вижу. Дальше тоже очень приятно. Спасибо. Значит, какие а индикаторы биологического возраста? Хм,
1:34:33
1 час 34 минуты 33 секунды
интересный вопрос. Ну, наверное, что может быть индикаторами для меня,
1:34:38
1 час 34 минуты 38 секунд
наверное, если я вижу, к примеру, да, я вижу,
1:34:42
1 час 34 минуты 42 секунды
например, если мы говорим именно об инструментальных исследованиях, да, ну,
1:34:47
1 час 34 минуты 47 секунд
я со своей стороны говорю, например, со стороны сердца, к примеру, да, я вижу неизменённые атеросклерозом клапаны, я вижу абсолютно нормальную работу сердца,
1:34:57
1 час 34 минуты 57 секунд
тонкие хорошие створочки, абсолютно нормальные полости, отличная фракция выброса, тонкая стеночка сосудов нигде не утолщенно без каких-либо включений.
1:35:08
1 час 35 минут 8 секунд
Ну вот, наверное, образно я бы вот что касается там со стороны сердца, там и проблема атеросклероза, вот что-то такое
1:35:15
1 час 35 минут 15 секунд
либо там на, например, если это УЗИ там я обязательно себе запишу вот индикаторы биологического вот, может быть, есть
1:35:22
1 час 35 минут 22 секунды
что-то как бы, что я смогу вам прислать именно вот как бы более последовательно.
1:35:27
1 час 35 минут 27 секунд
Я может быть немножечко сумбурно сейчас говорю биологического возраста. Очень интересный вопрос. Мне тоже даже стало очень интересно, ну вот как я это, да,
1:35:36

1 час 35 минут 36 секунд
для себя вижу. Или, допустим, УЗИ, там нет ни жирового гепатоза, вы смотрите,
1:35:40
1 час 35 минут 40 секунд
там абсолютно нормальная структура той же печени. То есть это тоже говорит о том, что это всё же в польза того, что здесь явно пациент и клиент наш, да,
1:35:50
1 час 35 минут 50 секунд
соблюдает, ведёт здоровый образ жизни и можно сказать, что у него а всё здесь нормально. Какие методы состояния
1:35:58
1 час 35 минут 58 секунд
микробиома? Тоже не знаю, не скажу. Это я должна посмотреть. микробиом обязательно вам то мы, я просто с этим
1:36:05
1 час 36 минут 5 секунд
не сталкиваюсь каждый день, но обязательно, конечно же, вот такие тонкости я всегда о себе буду отмечать и вам всегда пришлю обязательно там то,
1:36:14
1 час 36 минут 14 секунд
что я обещала вам, наверное, индексы тоже инсулинорезистентности пришлю, как я вам, а, проговорила, но не вывела просто их на слайд, обязательно это всё пришлю.
1:36:24
1 час 36 минут 24 секунды
микробиом и вот эти, расчёт индивидуального биологического возраста я себе записала и ответы на них вам вот буквально в ближайшее время пришлю. Вот.
1:36:35
1 час 36 минут 35 секунд
Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо,
1:36:37
1 час 36 минут 37 секунд
если вам действительно было, ну, это интересно, это нужно. Я очень надеюсь,
1:36:43
1 час 36 минут 43 секунды
что тогда и простите, что я вас так задержала, тогда всё это было не зря.
1:36:48
1 час 36 минут 48 секунд
Ещё раз благодарю вас. И вам большое спасибо. Спасибо. Всё, я не смею вас больше задерживать. Я вас отпускаю.
1:36:55
1 час 36 минут 55 секунд
Спасибо ещё раз вам. Спасибо.